



الشفقة بالذات وعلاقتها بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة

بمدينة الدمام

**Self-Compassion and its Relationship to Social Stigma among
Mothers of Children with Down Syndrome at the Supportive
Social Services Unit in Dammam**

إعداد

ليالي بنت مهدي بن إبراهيم الصلاح

Layali Mahdi Ibrahim Al-Salah

باحثه ماجستير التوجيه والارشاد النفسي- كلية التربية - جامعة الملك فيصل

د. سحر فاروق عبد الجيد علام

Dr. Sahar Farouk Abdul-Geid Allam

أستاذ مشارك بقسم التربية وعلم النفس- كلية التربية - جامعة الملك فيصل

Doi: 10.21608/jasep.2026.476356

استلام البحث : ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥

قبول النشر : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٥

الصلاح، ليالي بنت مهدي بن إبراهيم وعلام، سحر فاروق عبد الجيد (٢٠٢٦). الشفقة بالذات وعلاقتها بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام. *المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية*، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٥٦)، ٥٢٥ – ٥٧٨.

<http://jasep.journals.ekb.eg>

الشفقة بالذات وعلاقتها بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام

المستخلص:

هدف البحث إلى معرفة مستوى كل من الشفقة بالذات ، والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام والكشف عن طبيعة العلاقة بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية فضلاً عن الكشف عما إذا كانت هناك فروق بين الأمهات في الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية تُعزى إلى متغيري (المستوى التعليمي والعمر)؛ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الشفقة بالذات إعداد (2003) Neff ترجمة علام (٢٠١٧) ومقياس الوصمة الاجتماعية إعداد الريحانة (٢٠١٥) وتكوّنت العينة من (١٥٠) أمّاً من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام، تمّ اختيارهنّ بطريقة الحصر الشامل . وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تمّ استخدام المنهج الوصفي الارتباطي والمقارن، وتمّ الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة ضمن برنامج (SPSS) للتحقق من صحة الفروض، وتوصّلت نتائج الدراسة إلى أن أمهات أطفال متلازمة داون يتّسمن بمستوى متوسط من الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية. كما كشفت عن وجود علاقة عكسية (سلبية) ذات دلالة إحصائية بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الشفقة بالذات لدى الأمهات تُعزى لمتغير المستوى التعليمي. بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية لدى الأمهات تُعزى لمتغير العمر لصالح (أقل من ٣٠ سنة ومن ٤٠ إلى أقل من ٥٠) في بُعد اليقظة العقلية ولصالح الفئة العمرية (٦٠ فأكثر) في بُعد الإفراط في التوحد، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات أبعاد الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغير المستوى التعليمي لصالح (أمي) لكلٍ من البعد النفسي والاجتماعي ، وتوصلت الباحثة لعدد من التوصيات أهمها ضرورة زيادة جهود الجمعيات الخيرية والوزارات المعنية بتقديم خدمات الارشاد والتوجيه والتأهيل والحماية لأطفال متلازمة داون واسرهم .

Abstract

The study aimed to identify the level of self-compassion and social stigma among mothers of children with Down syndrome at the Social Services Support Unit in Dammam, in addition to identifying the level of social stigma experienced by mothers among the sample members. The study also aimed to



reveal the nature of the relationship between self-compassion and social stigma and identify whether there are differences between mothers in social stigma attributed to educational level and age variables. To achieve the objectives of this study, the female researcher used the self-compassion scale prepared by Neff, 2003, translated by Allam, 2017, and the social stigma scale prepared by Al-Rihana, 2015. The sample consisted of 150 mothers of children with Down syndrome at the Social Services Support Unit in Dammam. The sample members were selected by the complete enumeration method. To answer the study inquiries, the female researcher used the descriptive, correlational, and comparative approach, and utilized some suitable statistical methods within the SPSS software to validate the hypotheses. The results of the study revealed that mothers of children with Down syndrome are characterized by a moderate level of self-compassion and social stigma. The results revealed that there is a statistically significant inverse (negative) relationship between self-compassion and social stigma among mothers of children with Down syndrome and that there are no statistically significant differences in self-compassion among children attributed to the variable of educational level. There are statistically significant differences among mothers attributed to the age variable (in favor of those who are less than 30 and from 40 years to less than 50 years) concerning the dimension of mental alertness and in favor of the age group (60 years and above) concerning the dimension of excessive autism. There are no statistically significant differences in the degrees of the dimensions of social stigma among mothers of children with Down syndrome according to the age group. In addition, there are statistically significant differences in social stigma among mothers of children with Down syndrome attributed to the variable of educational level in favor of "illiterate" concerning the psychological and social dimensions. The researcher reached

a number of recommendations, the most important of which is the need to increase the efforts exerted by charities and ministries concerned with providing the services of guidance, rehabilitation, and protection of children with Down syndrome and their families.

أولاً: تمهيد:

يُشكّل الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية جزءاً من المجتمع، وهي ظاهرة معروفة على مدى العصور، ولا يوجد مجتمع يخلو من هذه الظاهرة، ومن بين هؤلاء فئة متلازمة داون، وهذه الفئة هي حالة جينية موجودة لدى الطفل منذ حدوث الحمل، وعندما يُولد طفل متلازمة داون فإن آثار ذلك ستعكس على الأسرة ككل، وخصوصاً الأم التي تقع عليها مسؤولية العناية بهذا الطفل ورعايته؛ ولكون الأم هي الأقرب لطفلها، فإن مشاعرها تنعكس على صحة الطفل والأسرة بأكملها (السيد، ٢٠١٨).

إن أمهات أطفال ذوي متلازمة داون يتكبّدن عبئاً كبيراً في رعاية هؤلاء الأطفال الذين يعانون من العديد من المشاكل الصحية، ومن الإعاقة العقلية، وهُنَّ بحاجة ماسة إلى الاهتمام بهن، والتخفيف عن كاهلهن، وحثهن على مواصلة طريقهن مع أطفالهن في رحلة التأهيل الشاقة والطويلة، كما أنهنَّ بحاجة إلى زرع الأمل في قلوبهنَّ في مستقبل أطفالهن ذوي الإعاقة (السيد، ٢٠١٧).

يعتبر مفهوم الشفقة بالذات من المفاهيم الحديثة في مجال علم النفس الإيجابي، حيث يرى علماء النفس الشفقة بالذات أنها إستراتيجية أساسية ومهمة، يُوظفها الفرد في الظروف والمواقف الحياتية الضاغطة؛ للتخلّص من المعاناة النفسية المرتبطة بالأمراض الجسدية والمزمنة، والتحرُّر من الأفكار المزعجة، والحد من تعاطف المشاعر السلبية، كمشاعر النقد الذاتي، والشعور بالذنب والخجل، وصولاً لتحقيق التوازن النفسي. ويُقصد بهذا المفهوم أيضاً تعهّد الفرد ذاته بالرعاية والجلم والرافة خلال الأوقات العصيبة، وتعزيز القدرات الشخصية في زيادة الشعور بالرضا عن الحياة، والسعادة والتفاؤل والمبادرة، وتنمية مشاعر الترابط الاجتماعي، وخفض القلق والاكتئاب (جوهر، ٢٠٢١).

ويُعتبر مفهوم الوصمة الاجتماعية من المفاهيم المعاصرة في علم النفس، حيث يشغل حيزاً واسعاً من الدراسات والبحوث لأهميته في حياة الناس، ومدى تأثيره على التفاعل الشخصي والاجتماعي الذي يوجد فيه؛ وذلك لأن الإنسان عبارة عن وحدة نفسية واجتماعية، وأي تأثير يطرأ على هذه الوحدة يصيب التفاعل الموجود بين طرفيها، وفضلاً على أن الوصمة الاجتماعية تُؤثر بشكل فعّال في العلاقات بين أفراد المجتمع، وأنها تلعب دوراً في الصحة النفسية للإنسان، وفي الحيز الاجتماعي والبيئي له، وما يترتب عليها من نتائج تُؤثر على الأسر التي لديها طفل معاق (البليوي، ٢٠١١).

تساعد الشفقة بالذات على الحد من المشكلات المختلفة التي تواجه العديد من الأفراد، والتقليل من الضغوط وأعراض الاكتئاب التي تواجههم، ويدعم ذلك ما أشارت إليه الدراسات السابقة، ومن وجود علاقة سببية بين الشفقة بالذات والكثير من المتغيرات النفسية الإيجابية؛ ما يُؤكّد ويدعم رؤيتها في كونها عاملاً مهماً داعماً في تحقيق الصحة النفسية، والرفاهية النفسية للفرد، وبالتالي يُنصَح بضرورة استخدامها في التدخلات العلاجية؛ لخفض الشعور بالاكتئاب (Neef and Costigan, 2014). وفي ضوء ما تقدّم تبحث الدراسة الراهنة العلاقة بين الوصمة الاجتماعية والشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون.

ثانياً: مشكلة الدراسة وتساولاتها

تتعرّض الأسرة للعديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها، وأن إعاقة أي فرد هي إعاقة لأسرته في الوقت نفسه، وتلعب العادات دوراً آخر في زيادة المشاكل حينما ترجع الإعاقة إلى أسباب وراثية تُثير منازعات واضحة بين الزوجين؛ لذا يجب توعية الأسرة بشكل عام، والأمهات بشكل خاص بكيفية التعامل مع الطفل، وبدورها في تحقيق نموه الشخصي والاجتماعي، واستقلاليته واعتماده على نفسه، ومساعدة الأسرة على فهم حالة الطفل وتقبّلها، ومعرفة مشكلاته واحتياجاته وإشباعها بطريقة ملائمة، وتبصيرها بالآثار السلبية المترتبة على مشاعرها السلبية، وتعريفها بالخدمات المتاحة للطفل في بيئته المحلية، وكيفية الحصول عليها (السيد، ٢٠١٨).

ولكي تتغلّب الأسرة على تلك المشاكل التي تواجهها نتيجة إصابة أبنائهم بمتلازمة داون، فهي بحاجة إلى مساندة اجتماعية؛ لأنها مصدر هام من مصادر الدعم الاجتماعي الفعّال الذي يحتاجه الإنسان كما أنها تلعب دوراً هاماً في إشباع الحاجة إلى الأمن النفسي، وتخفيف الضغوط التي تعاني منها أمهات هؤلاء الأطفال. (عبدالله وأبو المجد ٢٠٢٠).

وتظهر علامات الشفقة بالذات لدى الأمهات عندما تمرّ هذه الأم بظروف مؤلمة خارج قدرتها على السيطرة أو عندما تعاني من نظرة النقص من المجتمع. فالشفقة بالذات القائمة على التفهّم والتقبّل للمعاناة لا تعني أننا نرحّب بتلك المشاعر السلبية، ولكنها تعني أن نسمح لأنفسنا بالشعور بها مع ضرورة الوعي واليقظة. ومن ناحية أخرى، تركّز الشفقة بالذات على خلق موقف إيجابي وحالة ذهنية في التعامل بشكل خاص مع المعاناة، وعدم المبالغة في التعرّف على المواقف السلبية، فالأم التي تتصف بالشفقة بالذات هي التي تقوم بتهئية وراحة النفس بشكل فعال عند ظهور تجارب مؤلمة. وهناك العديد من الدراسات التي أشارت نتائجها إلى أن الشفقة بالذات ترتبط بشكل كبير بتقليل الوصمة الاجتماعية مثل

دراسات: Wong , Mak ,Liao , Chan (2016)

تشعر أسرة أطفال الإعاقة بالوصمة الاجتماعية والتي تنتج عن نظرة المجتمع لسلوك الطفل، وتعليق بعض الأشخاص على هذه التصرفات، وعدم فهم هذا المجتمع لاحتياجات هؤلاء الأطفال، والذي ينتج عنه أن الأسر غالباً ما تشعر بصعوبة الخروج بأطفالهم للمجتمع، وممارسة حياتهم الطبيعية؛ وللتغلب على هذا الشعور يجب أن تكتسب الأسرة مهارة الشفقة بالذات، والتي تساعد على الوعي والإدراك لحاجاتهم بلطف ورعاية لأنفسهم في مواقف الحياة الصعبة، كما أن الشفقة بالذات تُقلل من شدة وتهديد الأفكار والمشاعر السلبية.

ومن خلال عمل الباحثة كأخصائية نفسية بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ولقائي بالعديد من الأمهات للأطفال ذوي الإعاقات المختلفة لاحظت تفاوتاً في درجة تقبلهن لإعاقة طفل من أطفالهن بإحدى الإعاقات المعروفة ابتداءً من مرحلة الصدمة إلى مرحلة التقبل، وهي آخر مرحلة يجب أن يصل إليها والدا كل طفل معاق، وعليه فإن المرور من مرحلة الصدمة وحتى مرحلة التقبل قد تطول أو تقصر لدى بعض الأسر، وتتوقف على مدى قوة إيمان الفرد بالقضاء، وأن الصحة وتتمام العافية والخلة السليمة إنما هي إرادة الله سبحانه وتعالى.

وفي ضوء قلة البحوث العربية -في حدود اطلاع الباحثة- جاءت فكرة الدراسة الحالية التي تسعى إلى دراسة العلاقة بين الوصمة الاجتماعية التي تكون مصاحبة لوجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأسرة، والشفقة بالذات كطريقة لتعامل الفرد مع ذاته في المواقف الصعبة التي تسبب له المعاناة لدى أمهات الأطفال ذوي متلازمة داون.

وتحددت مشكلة البحث الراهن في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

١. ما مستوى الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟
٢. ما مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟
٣. هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟
٤. هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الشفقة لدى أمهات أطفال متلازمة داون بالذات تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي، العمر) ؟
٥. هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي، العمر) ؟

ثالثاً: أهداف البحث :

يسعى البحث الحالي إلى محاولة التحقق من الأهداف التالية:

- التعرف على مستوى الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام.
 - التعرف على مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام.
 - الكشف عن طبيعة العلاقة بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام.
 - التعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعرى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر).
 - التعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة احصائياً بين متوسطات درجات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعرى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر).
- رابعاً: أهمية البحث .

أولاً: الأهمية النظرية:

- تتنبق أهمية البحث من أهمية عينته وهن أمهات متلازمة داون، والتعرف على درجة وصمة الذات لديهن المترتبة على إصابة أبنائهن بالإعاقة، .
 - تتجلى أهمية البحث من أهمية مفهوم الشفقة بالذات، والذي يعتبر اتجاهاً صحيحاً للتعامل مع الذات في المواقف الضاغطة والخبرات الصعبة.
 - ندرة الدراسات العربية -في حدود اطلاع الباحثة- التي تناولت العلاقة بين الوصمة الاجتماعية والشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون والتي تعد إضافة وإثراءً للمكتبة العربية والمكتبة السعودية .
- ثانياً: الأهمية التطبيقية:

- يمكن أن تقيد نتائج البحث في تصميم برامج إرشادية وإقامة دورات تدريبية متخصصة تقدم للأسر (الأب - الأم) لتدريبهم على الأساليب الصحيحة في التعامل مع الأبناء من متلازمة داون.
- الخروج بتوصيات علمية موجهة إلى الأسرة السعودية بشكل خاص، وإلى المجتمع بشكل عام؛ وذلك للإسهام في تعزيز دور وأهمية وعي الأسرة لمعاملة الأبناء ذوي الاحتياجات بشكل سليم.
- يفيد الأخصائيين النفسيين في تصميم برامج التدريبية المرتبطة بتنمية الجوانب الإيجابية بشخصية الأمهات، وأيضاً لتنير الطريق أمام المهنيين الذين يتعاملون مع أسر أطفال متلازمة .

خامساً: مصطلحات الدراسة

أولاً: الشفقة بالذات self-compassion

تُعرّف (Neff 2003) الشفقة بالذات أنها اتجاه إيجابي تتخذه الأم تجاه ذاتها، يجعلها عطوفة ومتسامحة مع ذاتها في المواقف المؤلمة التي تشعر فيها بالإخفاق بدلاً

من انتقادها والقسوة عليها، وفهم خبراتها كجزء من الخبرات الإنسانية التي يعاني منها أغلب البشر، وتبني انفعالات وخبرات الذات في وعي يقظ، وشعورها بالرضا والمرونة في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة.

التعريف الإجرائي: هي الدرجة التي تحصل عليها أمهات أطفال متلازمة داون من خلال الإجابة على فقرات مقياس الشفقة بالذات المستخدم بالدراسة.

ثانيًا: الوصمة الاجتماعية Social Stigma

عرّف الريحانة (٢٠١٥) الوصمة الاجتماعية بأنها الصورة النمطية السلبية والمعتقدات الضارة لدى الناس، فضلاً عن الممارسات التمييزية أو غير المنطقية التي يمكن أن تنتج عن ذلك، على مستوى البنية الاجتماعية التي تسبب الاتجاهات السلبية غير العادلة، وتختلف باختلاف المجتمعات والعادات والتقاليد.

التعريف الإجرائي: هي الدرجة التي تحصل عليها أمهات أطفال متلازمة داون من خلال الإجابة على فقرات مقياس الوصمة الاجتماعية المستخدم بالدراسة.

ثالثًا: متلازمة داون

هي حالة جينية ناتجة عن اضطراب كروموسومي ترجع إلى زيادة في الكروموسوم رقم (٢١) أو انتقال كروموسوم أو التصاق جزء من كروموسوم آخر بهما تعني أن صاحبها لديه (٤٧) كروموسومًا بدلاً من (٤٦) ويؤدي هذا الخلل إلى خصائص جسمية مميزة مصحوبًا بإعاقة عقلية، ويحدث هذا الاضطراب أثناء فترة الحمل ولا يمكن علاجه. (أبو زيد، ٢٠١٥).

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولاً: الشفقة بالذات self-compassion:

تعتبر دراسة الشفقة جديدة نسبياً في علم النفس؛ ونظراً لحدائته كموضوع في علم النفس فقد حظي هذا المفهوم في العقدين الأخيرين بأهمية بالغة في الدراسات والبحوث الأجنبية. وقد بدأ الاهتمام العلمي الفعلي بهذا المفهوم عام ٢٠٠٣ على يد عالمة الأمريكية Kristin Neff، والتي يعود لها الفضل في تطوير أول أداة لقياس مفهوم الشفقة بالذات (حنون والقرالة، ٢٠٢٢).

وقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم الشفقة، فعلماء النفس في الغرب نظروا إليه من زاوية العطف على الآخرين اعتباره خاصية إنسانية لفهم معاناة الآخرين، والرغبة في عمل أي شيء لهم؛ وذلك بهدف التقليل من شدة معاناتهم وألامهم، في حين رأى منظّرو علم النفس البوذي أن الشفقة بالذات هي عنصر مهم من عناصر الصحة النفسية، والتي تتضمن اللطف أو الرأفة بالذات، وعدم إلقاء اللوم عليها، أو انتقادها بشدة عندما يمرّ الفرد بتلك الخبرات غير السارة (العاسمي، ٢٠١٤).

ترى الباحثة أن مفهوم الشفقة بالذات يتميز بأنه أحد أبعاد البناء النفسي للفرد، ويتضمن المفهوم الرفق بالذات، والرفق بالآخرين، ويمكن اعتباره بناءً متعدد الأبعاد

لكنه يتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية هي: اللطف بالذات، واليقظة العقلية، والإنسانية المشتركة.

تعريف الشفقة بالذات:

تعددت الترجمات العربية للمصطلح الإنجليزي self-compassion فمنهم من ترجمه وعرفه بالشفقة بالذات، والرأفة بالذات، والعطف بالذات، والتراحم بالذات، ومنهم من عرفه بتفهّم الفرد لمعاناته، واعترافه بأخطائه والتسامح معها، والاستجابة للأحداث بلطف؛ ما يساهم في إعادة التوازن للذات بعد اضطرابها الناتج عن المعاناة (kainins, 2015).

وأضاف التريني (٢٠٢٢) أن الشفقة بالذات هي "نظر الفرد لنقاط ضعفه وأخطائه وإخفاقاته بمزيد من الانفتاح والتسامح والتفهّم لإنسانيته بدلاً من النظرة الضيقة للأخطاء والشعور بالفشل التام".

كما عرفها (pommier,etal (2022 بأنها "استجابة محسومة للمعاناة، وتتضمن الاندماج اليقظ ذهنياً للفرد في معاناة الآخرين، واستجابته بلطف مع مواقف المحن التي يتعرضون لها، والاعتقاد بالترابط الإنساني مع الآخرين الذي يؤدي إلى رغبة حقيقية في تخفيف المعاناة".

من خلال ما سبق، ترى الباحثة الشفقة بالذات أنها لطف الفرد بذاته وتقبُّله لها في المواقف المؤلمة أو مواقف الفشل وعدم الانتقاد وتوجيه اللوم لها بشكل مفرط، وكذلك الاعتقاد أن ما يحدث للفرد يحدث للجميع، وأن جميع الأفراد يشعرون بنفس مشاعره.

مكونات الشفقة بالذات:

- اللطف بالذات مقابل الحكم على الذات: Self-kindness versus self judgment

ويشير إلى قدرة الفرد أن يكون رحيماً ولطيفاً وداعماً ومتفهِّماً نحو نفسه في مواقف الألم أو الفشل، وعند المعاناة من الأحداث السلبية، بدلاً من النقد الذاتي اللاذع، وإصدار الأحكام القاسية عليها وعلى عيوبه الشخصية، ويتضمن أيضاً التهذئة الإيجابية والراحة النفسية في أوقات المعاناة والحزن. (حنون، ٢٠٢٢).

- الإنسانية المشتركة مقابل العزلة: Common humanity versus isolation

تعني إدراك الفرد أن خبراته وتجاربه (المعاناة والعيوب الشخصية) جزء من الخبرة الإنسانية الأكبر، وفهم أن كل البشر يفتشون ويخطؤون، وأن كل الناس يعيشون حياة غير كاملة، بدلاً من الشعور بالعزلة لعدم الكمال، والشعور المتمركز حول الذات كما لو كنت أنا الشخص الوحيد الذي فشل أو الذي يعاني، وهذا يمكن الفرد من تطوير منظور أوسع وأكثر ترابطاً فيما يتعلق بالعيوب والصعوبات، بدلاً من الشعور بالعزلة بسبب الفشل أو الإخفاق. (Akin&Akin, 2015).

- اليقظة العقلية مقابل التوحد المفرط: Mindfulness over identification versus

هو المكون الثالث في الشفقة بالذات، ويُقصد به احتواء الفرد الأفكار والمشاعر والخبرات المؤلمة في الوعي الإدراكي المتوازن، دون الرفض والانغماس أو الاستغراق في الجوانب السلبية المبالغ فيها، أو في خبرات حياة الفرد المؤلمة، والمبالغة في رواياته الدرامية عن معاناته (وتُسمى بالتوحد المفرط). كما يعني القدرة على الانتباه إلى التجربة اللحظية، مع الشعور بالارتباط التعاطفي، ورباطة الجأش، وزيادة الوعي المتمركز حول الحاضر؛ ما يجعلهم أكثر إدراكًا، وأقل انخراطًا في التأمل الاجتراري، وفيه أيضًا يحاول الفرد أن تكون مشاعره متوازنة عندما يواجه انفعالاتٍ غير مريحة، ويقابله التوحد المفرط، وهو حالة عقلية متحكمة في عقل الفرد، وتجبره على الاعتقاد بأن كل شيء يمثل مأزقًا عندما يشعر بالإحباط. (المنشاوي، ٢٠١٦).

النظريات المفسرة للشفقة بالذات:

(١) نظرية نيف (Neff, 2003):

قسّمت نيف الشفقة بالذات إلى ثلاثة أبعاد، وأشارت أن هذه الأبعاد تتفاعل فيما بينها لخلق إطار وجداني متسامح للعقل، وهذه الأبعاد هي: اللطف بالذات مقابل الحكم على الذات: ويشير إلى الرفق بالذات في حالة الإحباط بدلًا من لومها، ونقد الذات الإنسانية المشتركة مقابل العزلة: فالخبرات المؤلمة للفرد جزء مما يعانيه معظم الأفراد، واليقظة العقلية مقابل الإفراط في التوحد: وهي حالة من الوعي المتوازن في رؤية وتحديد الأفكار والمشاعر المؤلمة بدلًا من الإفراط فيها، ومن ثمّ فإن الشفقة بالذات هي خبرة إنسانية مشتركة تقوم على مشاركة الأحزان والأفراح، كما أن العطف بالذات يقوى عندما يدرك الفرد معاناة الآخرين، ويبحث عن سبل لمساعدتهم ليتخلّصوا مما هم فيه من الألم؛ لذا فهو يوازن بين احتياجاته الشخصية واحتياجات الآخرين (محمد، ٢٠١٩).

(٢) نظرية الارتباط بالذات The Self –in Relation Model

تُعدّ أعمال جوديت جوردان من أقرب النماذج تفسيرًا لمفهوم الشفقة على الذات، والتي تُعدّ أحد مؤسسي نموذج العلاقات الذاتية للتطور النفسي للمرأة (Jordan, 1997)، وقد كتبت جوردان بإيجاز عن مفهوم الشفقة على الذات في كتاباتها، على الرغم من أن الأفكار لم يتمّ تفصيلها بالكامل، واصفة هذا المفهوم بأنه عملية يتبنّى فيها الفرد موقفًا من عدم إصدار الأحكام والانفتاح على الذات، ومن وجهة النظر هذه، ترتبط الشفقة على الذات ارتباطًا وثيقًا بالتعاطف مع الآخرين، والذي يتمّ تعريفه من حيث الشعور بالارتباط العاطفي بالآخرين والاعتراف بالتشابه مع الآخرين، حيث

يتعاطف المرء مع الفشل الحتمي والخسارة المرتبطة بكونك إنساناً. (NeffK,2003). (a).

٣) النظرية الإنسانية (لماسلو) Humanistic Theory (Maslow)

تشير النظرية الإنسانية إلى أهمية مساعدة الآخرين وتقبلهم ومشاركتهم آلامهم، وقد شجّع ماسلو على مساعدة الآخرين، والشفقة بهم، والتعاطف معهم في حالة معاناتهم وفشلهم، كما شجّع على فهم الذات والتعاطف معها، وقد اهتم روجرز (Rogers) بمفهوم الشفقة بالذات كأحد أهداف العلاج المتمركز حول المسترشد، ومساعدة العميل على أن يكون أكثر وعياً وتقبلاً لذاته، مع قدرته على التعبير عن احتياجاته بشكل واضح وصريح، وهو ما يُطلق على التقبل الذاتي غير المشروط (سعد، ٢٠٢٠).

ثانياً: الوصمة الاجتماعية Social Stigma

مفهوم الوصمة الاجتماعية:

عرّف (Deborah 2011) الوصم بشكل عام بأنه إلحاق أو إلصاق مسميات غير مرغوب فيها بالفرد من جانب الآخرين على نحو يحرمه من التقبل الاجتماعي أو تأييد المجتمع له؛ لأنه شخص مختلف عن بقية الأشخاص في المجتمع، ويكون هذا الاختلاف في خاصية من خصائص الجسم أو العقل أو النفسية أو الاجتماعية التي تجعله مغترباً عن المجتمع الذي يعيش فيه ومرفوضاً منه؛ ما يجعله يشعر بنقص التوازن النفسي والاجتماعي.

وذكر الزبيد (٢٠٠٥) تعريفاً للعالم ألونزو ورينولدز للوصم الاجتماعي بأن الوصم هو الحط من القيمة الفردية، وتلويت التنشئة الاجتماعية، التي تهدد نظرة الأفراد لأنفسهم.

أنماط الوصمة الاجتماعية:

- وصمة جسمية.
- وصمة عقلية.
- وصمة حسية.
- وصمة لغوية.
- وصمة عرقية.
- وصمة جنائية.

ترى الباحثة أن كل صور الوصم الاجتماعي تحتاج إلى برامج متخصصة للتعامل معها على المستوى المجتمعي والمؤسسات العلاجية لكيلا تتفاقم المشكلة وتتعرّس العملية العلاجية وكلما انخفض مستوى الوصم ظهر التحسّن العلاجي، وهو قد يحتاج إلى توعية نفسية واجتماعية لقبوله.

العوامل المؤدية للشعور بالوصمة الاجتماعية:

بوعي أو بلا وعي أثناء تفاعلنا مع الآخرين نضع علامات أو إشارات أي سمات معينة للفرد قد يكون نتيجة مواقف معينة أو الجنس أو لون البشرة أو المهنة أو اللغة، فيحكم من خلال ذلك أن الفرد له تصرفات وسلوكيات محددة على الرغم أنه ليس له علاقة بها، فتلك هي الوصمة (Blume,2002). يرى بكر أن هناك شرطين لإلحاق الوصمة بالفاعل (أبو نور، ٢٠٠٨):

- استجابة الجماعة لكل ما يتعلق بعملية الوصم.
- أن يعيد الفرد الموصوم تقييمه لنفسه وفهمه لذاته؛ ما قد يعتقد معه بأنه مجرم، وينتج عن ذلك حدوث تحوّل في شخصيته، وفي قيامه بدوره الاجتماعي.

وصم الأفراد من قبل المجتمع بالجريمة والمرض والانحراف قد يكون مبرر أو غير مبرر مثل أن هناك شخصاً قام بفعل يعارض قواعد ومعايير المجتمع إلا أن المجتمع لا يوصمهم بذلك؛ لكون سمعتهم أو مكانتهم الاجتماعية رفيعة، ولكن إذا وصم المجتمع شخصاً آخر بأنه فعل ذلك على الرغم من أنه لم يتعدّ القواعد والمعايير الخاصة بالمجتمع، فعلى الرغم من ذلك يوصمهم المجتمع؛ لأنهم أشخاص منحدرين من وسط اجتماعي متدنٍ أو بيئة موبوءة أو من عائلة ارتكب أفرادها الجرائم ضد المجتمع، ولا يوجد هناك من يدافع عنهم أو يكفّ عنهم المظالم؛ لذا قد يضطر إلى ارتكاب الجرائم ضد المجتمع للانتقام منه (الحسن، ٢٠٠٥)

الآثار السلبية الناتجة عن الوصمة الاجتماعية:

- السلوك السلبي:

- التوجهات والتوقعات السلبية:

- التمييز السلبي للموصومين:

ترى الباحثة أن الأسرة لها دور كبير في تكوين سلوك الفرد، وفي تكوين القيم والمبادئ الاجتماعية والثقافية، حيث إن الروابط الأسرية لها دور إيجابي في التخلص من الضغوطات الاجتماعية.

الوصمة الاجتماعية وردة فعل الموصوم:

تتحدّد ردة فعل الموصوم حسب قوة الوصمة وسببها، ولكن بشكل عام فإن هناك العديد من السلوكيات التي قد تبدو على الشخص ردّاً على الوصمة مثل:

■ إخفاء مصدر الوصمة، وخاصة الصفة الخارجية المسيّبة للوصمة بقدر الإمكان، وهنا يتحاشى الشخص أن تكون للسمة أو للسلوك المسبب للوصمة أيّ تأثير أو أن يستخدم كمقياس للتقييم أثناء التفاعل.

■ الانسحاب وتحديد العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين الذين يتفهمون الموقف، أو الأشخاص الحاملين لخاصية الوصمة نفسها، فتقليل العلاقات يساعد على تقليل الآثار المصاحبة للوصمة ونتائجها النفسية والاجتماعية.

■ أن يقوم الموصوم بتتقيف الآخرين عن السمة أو الخاصية المسببة للوصمة حتى تضعف حدة الوصم أو يتخلص من النظرة السلبية له (القصير، ٢٠٠١).

وكذلك يعاني الموصوم من عدم مصاهرتة، ومن العار الاجتماعي الذي يلحق به، وعدم تقبل صداقته، بالإضافة إلى إحساسه بأنه موصوم؛ ما قد يؤدي إلى تدهور حالته النفسية والصحية والشعور بالدونية وتحقير الذات.

النظريات المفسرة للوصمة الاجتماعية:

○ النظرية المعرفية التنموية: The Cognitive- Theory development

وتفسر هذه النظرية الوصمة من خلال تطور الإدراك الاجتماعي، أو التفكير في الناس وفهم تصرفاتهم في إطار السلوك الاجتماعي، فالوصمة قد ترتبط على سبيل المثال بنمو القدرة على التمييز بين الناس، وتصنيفهم إلى مجموعات، وتشكيل هوية المرء فيما يتعلق بالآخرين، وتفسير سلوك الآخرين، فهذا كله يخضع للمنظور المعرفي التنموي وتطور ردود فعل الفرد في مراحل العمر المختلفة، حيث يختلف حكم الفرد على مجموعة من الأفراد الذي يصدر عنه، وهو طفل عن حكمه على المجموعة نفسها وهو شاب، وكذلك يختلف عن حكمه وهو راشد، وهذا معنى النظرية المعرفية التنموية (الشاذلي، ٢٠١٨).

○ النظرية التفاعلية الرمزية Theory Integrative Social

تنظر النظرية التفاعلية الرمزية إلى الرموز كمعنى باعتبارها القدرة التي تمتلكها الكائنات الإنسانية للتعبير عن الأفكار باستخدامها في تعاملاتهم مع بعضهم البعض، وتستخدم الرموز للتعبير عن شيء له دلالة اجتماعية، ويشير مفهوم الرمز إلى الأشياء التي ترمز إلى شيء آخر، أو يكون لها معانٍ أعمق من الجانب السطحي للرمز، ويتم تحديد معنى الرموز عن طريق الاتفاق بين أعضاء الجماعة (الشاذلي، ٢٠١٨).

○ نظرية الوصمة Stigma Theory

يرجع أصل الوصمة Stigma إلى ما كتبه تانتوم عام ١٩٣٨ عن أن ما يؤدي إلى خلق مجرم هو الكيفية التي يعامله بها الآخرون حيث أشار إلى أن تلك الكيفية وما يصاحبها من عمليات مرحلية وربما يلزمها من تأثير وتأثر متبادل (أبو نور، ٢٠٠٨).

ويطلق على نظرية الوصمة مُسمًى آخر وهو نظرية التسمية الانحرافية، وتعرض هذه النظرية لمجموعة من القضايا من بينها اختلاف موقف مرتكبي الجريمة عن موقف الجماعة التي ينتمي إليها، ففي حين يرى مرتكب الجريمة أو سلوكه يعتبر مخالفة ترى الجماعة أن هذا السلوك خروج عن معاييرها، وتوصم هذا الفرد الذي ارتكب السلوك بأنه مجرم، وهذه الوصمة لها دور كبير في دفع الفرد إلى الانحراف والجريمة (عباس، ٢٠١١).

ثالثًا: متلازمة داون Down Syndrome

مفهوم متلازمة داون:

تعتبر متلازمة داون من أشهر أنواع الضعف العقلي التي اهتمَّ بها الباحثون، ومع أنها من أكثر الأنواع وضوحًا في التشخيص، إلا أنها من أكثرها غموضًا في معرفة الأسباب التي تُؤدِّي إلى حدوثها، وهناك مجموعة أعراض منتظمة مع بعضها تُعطي طابعًا مميزًا يجعل ضعاف العقول من النوع "التريزومي ٢١" (الشمراي، ٢٠١٥).

وهي حالة جينية ناتجة عن وجود كروموسوم زائد في الخلية، وهو يعني أن صاحبها لديه ٤٧ كروموسومًا بدلًا من ٤٦ كروموسومًا، وهي تحدث نتيجة خلل جيني في وقت حدوث الحمل نفسه أو أثناء فترة الحمل، وليست حالة مرضية، ولا يمكن علاجها، وعادة تكون مصحوبة بتخلف عقلي (مؤسسة داون سندروم، ٢٠٠١). وترى الباحثة أن متلازمة داون هي حالة يولد بها الطفل؛ نتيجة لخلل في الكروموسومات لتسبب درجات متفاوتة من التخلف، سواء في النمو الجسمي أو العقلي أو العضلي، وتحتوي كل خلية من خلايا أجسامهم على ٤٧ كروموسومًا بدلًا من ٤٦، وأنها تحدث في كل أنحاء العالم بين الأجناس البشرية كلها، وبمستوياتها المعيشية المختلفة، وأن السبب الرئيسي لهذه الحالة غير معروف حتى الآن، ولكن خطأ ما يحصل بالطفرة أثناء انقسام الخلية، ولا يكون سببه عملاً قامت به الأم أثناء الحمل. وتلث أفراد متلازمة داون لديهم عيب خلقي في القلب والجهاز التنفسي والهضمي.

تعريف أطفال متلازمة داون:

يُعرّف عباس (٢٠٠٩) أطفال متلازمة داون بأنهم الأطفال المصابون بمجموعة من الخصائص الجسمية والعقلية المميزة لحالة مرضية يتمُّ تشخيصها بفحص عينة من دم الطفل، حيث تظهر العينة وجود كروموسوم إضافي في الخلايا الجسمية للطفل، وسُميت المتلازمة باسم "داون" Down نسبة إلى الطبيب الذي اكتشف الخصائص المميزة للحالة، وكان ذلك في عام ١٨٦٦م، حيث كان يطلق على الاضطراب. قبل هذا التاريخ. اسم: "المنغولية".

فيما ذكرت عسلي (٢٠٠٦) أن متلازمة داون هي عبارة عن مرض خلقي، أي: عند الطفل منذ الولادة، وأن المرض كان لديه منذ اللحظة التي خُلِق فيها، وهو ناتج عن زيادة في عدد الصبغات (الكروموسومات)، والصبغات هي عبارة عن عصابات صغيرة داخل نواه الخلية تحمل هذه الصبغات داخلها تفاصيل كاملة لخلق الإنسان، فيحمل الشخص العادي ذكرًا كان أو أنثى ٤٦ صبغة، وهذه الصبغات تأتي على شكل أزواج، فكل زوج فيه صبغتان (٢٣ زوجًا أو ٤٦ صبغية) وهذه الأزواج مرقمة من واحد إلى اثنين وعشرين، بينما الزوج الأخير الزوج ٢٣ لا يعطي رقمًا بل

يُسمَّى الزوج محدد الجنس، يرث الإنسان نصف عدد الصبغات (٢٣) من أمه، والأخرى من أبيه.

وترى الباحثة أن متلازمة دوان سندروم هو اضطراب جيني يتسبب في زيادة عدد الكروموسومات من ٤٦ لتصبح ٤٧ كروموسوماً؛ وذلك عند حدوث انقسام غير طبيعي للخلايا في المادة الوراثية، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تنتم بها متلازمة داون. أنواع متلازمة داون:

١. التثلث الصبغي رقم ٢١:

٢. المنتقل: التحول الانتقالي.

٣. الفسيفسائية (mosaic):

وترى الباحثة أن أخطر أنواع متلازمة داون هو النوع الأول المعروف باسم متلازمة داون ذات التثلث الصبغي ٢١ لأن أغلب الأطفال يُولدون بمشاكل وعيوب في القلب والمعدة والأمعاء والعضلات، ويعانون من مشاكل في السمع والرؤية وأمراض الغدد والسكري، أما أخف أنواع متلازمة داون المعروف باسم الفسيفسائية فهو الذي يشكل ٢% من مجموع الأطفال المصابين بمتلازمة داون. العوامل المسببة لحدوث متلازمة داون:

العوامل الوراثية وتتضمن:

أ- وراثية خاصة التخلف العقلي: انتقال خصائص وراثية شاذة (شذوذ الكروموسومات - شذوذ الجنيات ٩ ويعتقد بعض الأخصائيين أن خلل الهرمون، أشعة x، الإصابة بالحمى يمكن أن يكون السبب في الخلية وحدث متلازمة داون.

ب- عوامل بيولوجية مثل العامل الريزومي RH.

العوامل البيئية: والمتمثلة في تعرّض الجنين للعدوى الفيروسية البكتيرية، الإشعاعات، الاستخدام السيئ للأدوية، سوء تغذية الأم الحامل، أمراض الطفولة (التهاب المخ، الالتهاب السحائي، شلل المخ، أمراض الغذاء (جعفر، ٢٠٠١).

أعراض متلازمة داون وخصائصها:

أعراض متلازمة داون تتمثل في أن العينين منحرفتان لأعلى من الخارج، مع انثناء في الزوايا الخارجية، الرأس صغير الحجم، مع تسطح في الجهة الخلفية، الشعر ناعم وخفيف، والأذن صغيرة وملتصقة إلى سطح الرأس، والفم صغير، وكذلك الشفاه بحيث يظهر اللسان كبيراً، والأنف صغير ومسطح، الأظراف قصيرة، واليد عريضة وتحتوي خطأً عرضياً واحداً، وارتخاء وضعف في العضلات، وتأخر في النمو والتطور، وتأخر في النمو العقلي مع صعوبات في النطق والتعلم، وتزداد نسبة حدوث التشوهات الخلقية، مثل زيادة نسبة حدوث تشوهات خلقية على القلب، عيوب

خلقية في الأمعاء، ويتم التشخيص بواسطة العلامات السريرية، الفحص الصبغي (بدر، ٢٠١١).

ترى الباحثة أن كل شخص مصاب بمتلازمة داون هو فرد يعاني مشكلات عقلية نمائية خفيفة أو معتدلة أو شديدة، وقد يكون البعض أصحاء، بينما البعض الآخر يعانون مشكلات صحية كبيرة كتشوهات القلب، وأن الأطفال والبالغين المصابين بمتلازمة داون يتميزون بلامح وجه مميزة.

المشكلات التي تواجه أطفال متلازمة داون: يعاني أطفال متلازمة داون مثل باقي فئات الإعاقة الذهنية من مشكلات عديدة نذكر منها:

١- المشكلات الصحية:

وتتمثل في الإصابة بالأمراض الجسمية، والصعوبات الحسية، وأمراض الجهاز التنفسي، والصعوبات السمعية والبصرية، واعتلال الصحة بوجه عام، بالإضافة إلى: أ- زيادة الوزن؛ وذلك بسبب نوعيات الأكل، وقلة الحركة؛ لارتخاء العضلات مع تأخر المشي والحركة.

ب- فقدان حاسة السمع في أذن واحدة أو في الاثنين فيما بين ٦٠-٨٠ % من الحالات.

ج- أمراض القلب (الثقوب في جدران ووسط القلب، ثقوب عجز في البطن، عجز في الأذنين، وتشوهات صمامات القلب).

د- مشاكل في الغدة الدرقية (عبدالله، ٢٠٠٤).

٢- المشكلات الاجتماعية:

حيث يعاني أطفال متلازمة داون من النظرة الدونية من جانب المجتمع، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى السخرية والنفور منهم، فهم يجدون صعوبة في تكوين العلاقات مع الأشقاء أو الوالدين، فضلاً عن شعور أفراد الأسرة بالذنب أو العار؛ نتيجة إصابة طفلها بالإعاقة، والوسائل، والمهارات الصحية، وارتداء الملابس، ومهارات التواصل الاجتماعي، وتحمل المسؤولية (الروسان، ٢٠٠٥).

٣- المشكلات التعليمية ومنها:

أ- صعوبة الاندماج في التعليم العام أو البرامج الخاصة بكل فئة. ب- المشكلات النفسية السلوكية التي تحول دون مواكبة الفئات الخاصة المستوى التعليمي مثل غيرهم من أفراد المجتمع.

ج- عدم توفر مدارس خاصة كافية لاستيعاب الفئات الخاصة على اختلاف أنماط الإعاقة التي يعانون منها (أبو المعاطي، ٢٠٠٤)

٤- المشكلات السلوكية:

فالسلوك العدواني هو إحدى المشكلات السلوكية التي تواجه القائمين على تعليم وتربية وتأهيل أطفال متلازمة داون الذين يعانون من هذا السلوك، حيث يعاني أطفال

داون من مشكلات السلوك العدوانية التي لا تجعلهم يستطيعون بناء علاقات مع الآخرين، ويعيشون في حالة صراع مع الآخرين، ويُمثل هذا السلوك إعاقة حقيقية تحول دون تعليمهم ونموهم (عبدالله، ٢٠٠٤).

تري الباحثة أن المصابين بمتلازمة داون يواجهون صعوبات كثيرة، سواء في التعليم أو العمل أو من خلال نظرة المجتمع، وفي رأي الباحثة أنه طفل مختلف ومميز ومبدع، ويجب علينا اكتشاف مواهبه، ويجب أن نستشير المختصين لنساعده وندرجه.

مظاهر الرعاية الذاتية لدى أطفال متلازمة داون:

إن للوالدين دورًا رئيسًا في تنمية الاستقلالية لدى الأطفال متلازمة داون، وإن الإفراط في الحماية من قبل الوالدين قد يؤدي إلى معاملة الكبار منهم معاملة الأطفال، وإلى مشاكل في الثقة بالنفس والقصور في الشخصية (العبري، ٢٠٠٣).

أما عن توقعات اكتساب مهارة العناية بالذات فنجد أن طفل متلازمة داون في عمر ١٢ شهرًا يكتسب مهارة الأكل بالأصابع، وفي عمر ٢٠ شهرًا يستخدم الملعقة والشوكة، وفي عمر ٤٨ شهرًا يتحكم في المثانة، وفي عمر ٤٢ شهرًا يستطيع طفل متلازمة داون التحكم بعملية الإخراج، وفي عمر ٤٠ شهرًا يخلع ملابسه، وأما بالنسبة إلى ارتداء الملابس فعندما يكون عمره ٥٨ شهرًا يستطيع أن يرتديها دون مساعدة الآخرين (الملق، ٢٠٠١). ولذلك يجب على أمهات وآباء أطفال متلازمة داون عدم إظهار الدعم الوجداني لأطفالهم، بل الحزم عندما يرفض الأطفال أداء مهمة بمقدورهم أداؤها.

مظاهر النمو الشخصي والاجتماعي لدى أطفال متلازمة داون:

إن النمو الاجتماعي لدى أطفال متلازمة داون يكون أسرع، ومتقدمًا عن النمو العقلي بعدة سنوات، كما يجب الاهتمام بتقييم النضج الاجتماعي للأطفال، وكل ما يحتاجه هؤلاء الأطفال في مرحلة من مراحل نضجهم الاجتماعي. وكما أن أطفال متلازمة داون اجتماعيون أكثر من الأطفال المتخلفين عقليًا، والميل الاجتماعي أو المخالطة هي خاصية لديهم، وهذا الميل الاجتماعي فطري، وهم أكثر طواعية في التطبيع الاجتماعي من حالات التخلف العقلي الأخرى، إن طفل متلازمة داون يوصف على أنه هادئ، ومبتهج، وسهل الانقياد للقواعد الاجتماعية (العبري، ٢٠٠٣).

يشير الملق (٢٠٠١) إلى أن سبب اتصاف أطفال متلازمة داون بالعناد هو شعورهم باليأس الناتج من عدم فهم أو معرفة الناس للطرق الاتصالية التي يُعبرون بها عن أنفسهم أو عدم فهمهم لما يقوله الناس من حديث.

وأطفال متلازمة داون لا يقلدون السلوك الاجتماعي المناسب الذي يصدر عن العاديين بصورة تلقائية، بل حدوث ذلك يتطلب استخدام إستراتيجيات تدخل علاجي منظمة ومكثفة (العميري، ٢٠٠١).

رابعاً: الدراسات السابقة

المحور الأول: الدراسات التي تناولت الشفقة بالذات وعلاقتها ببعض المتغيرات:

دراسة عيسى (٢٠٢٣) توصلت إلى وجود علاقة موجبة دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات وبعد القبول (من الاتجاهات الوالدية)، وأيضاً وجود علاقة سالبة دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات وبعد الحماية الزائدة (من الاتجاهات الوالدية)، كما أسفرت النتائج أيضاً عن وجود علاقة موجبة دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات والرضا عن الحياة عند مستوى دلالة (٠,٠١) لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.

دراسة أبو حشيش (٢٠٢٢) توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي. ووجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الشفقة بالذات لصالح المجموعة التجريبية.

ودراسة جواهر (٢٠٢١) فقد توصلت إلى دراسة وجود علاقة ارتباطية دالة سالبة بين درجات عينة الدراسة على مقياس الشفقة بالذات ودرجاتهم على قائمة بيك للاكتئاب، كما توصلت الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بمستوى الاكتئاب النفسي من مستوى الشفقة بالذات، وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج التدريبي حيث ظهر تحسن ملحوظ في الشفقة بالذات، وانخفاض واضح في أعراض الاكتئاب النفسي بعد تطبيق البرنامج وبعد فترة المتابعة.

أما دراسة السمحة (٢٠٢٠) فقد توصلت إلى فروق ذات دلالة إحصائية في الدرجة الكلية للشفقة بالذات بين الآباء والأمهات لصالح الآباء، كما أشارت النتائج أيضاً إلى أن أبعاد الشفقة بالذات (اليقظة العقلية، والعزلة، والتقصص المفرط) تسهم في التنبؤ بالدرجة الكلية للشعور بالتماسك.

وكذلك دراسة رضوان (٢٠١٩) فقد توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشفقة بالذات والصمود النفسي، ووجود علاقة ارتباطية سالبة بين الشفقة بالذات وقلق المستقبل، وكذلك أسفرت النتائج عن إسهام أبعاد الصمود النفسي في التنبؤ بالشفقة بالذات، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الشفقة بالذات ترجع إلى متغير نوع إعاقة أو اضطراب الابن لصالح ذوي الإعاقة السمعية، وتبعاً للمستوى التعليمي للأم لصالح المستوى الأعلى، وأيضاً تبعاً لمتغير عمر الأم لصالح العمر الأكبر (من ٣٦-٤٢) سنة.

ودراسة محمد (٢٠١٨) توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين أبعاد الشفقة بالذات، وبين سمات الشخصية لدى آباء وأمهات ذوي الإعاقة العقلية، كما

أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائية بين أفراد العينة على مقياس الشفقة بالذات حسب النوع، ومستوى التعليم، والمستوى الاجتماعي -الاقتصادي.

أما دراسة مختار ومجد (٢٠١٧) فقد توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية دالة سالبة بين الشفقة والاكتئاب، كما أشارت إلى وجود علاقة ارتباطية دالة سالبة بين الرفاهية النفسية والاكتئاب، وكذلك وجود تأثير دال لتفاعل كلٍّ من الشفقة بالذات والرفاهية النفسية على الشعور بالاكتئاب لدى عينة الدراسة، كذلك أشارت النتائج إلى أن نموذج تحليل المسار للعلاقة بين الشفقة بالذات والرفاهية النفسية والاكتئاب قد حقق مواصفات حسن المطابقة.

أما دراسة أرونز (2017) Arnos فقد توصلت إلى عدم وجود فروق في إدراك الضغوط والشفقة بالذات لدى أفراد العينة وفقاً لمتغير عمر الطفل، وأظهرت النتائج أيضاً أن أفراد العينة يتسمون بمستوى مرتفع من الشفقة بالذات، ومستوى منخفض من إدراك الضغوط.

و دراسة (2017) Kristina فقد توصلت إلى وجود علاقة بين الضغوط والشفقة بالذات لدى أفراد عينة الدراسة.

وكذلك دراسة (2015) Aydan فقد توصلت إلى وجود فروق في الشفقة بالذات بين الآباء والأمهات لصالح الآباء، كما تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آباء الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال المعاقين عقلياً من حيث متوسط الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات.
المحور الثاني: الدراسات التي تناولت الوصمة الاجتماعية وعلاقتها ببعض المتغيرات:

دراسة محمد (٢٠٢٢) فقد توصلت إلى وجود ارتباط موجب بين الألكسيثيميا والوصمة الاجتماعية، ووجود علاقة ارتباطية موجبة بين كلٍّ من أساليب مواجهة الضغوط المتمثلة في (الإنكار- لوم الذات- الكبح)، بينما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين كلٍّ من أساليب مواجهة الضغوط المتمثلة في (إعادة التقييم الإيجابي للمشكلة- أسلوب المواجهة لحل المشكلة- الدعم الاجتماعي- التنفيس الانفعالي).

بينما دراسة محمد (٢٠٢١) فقد توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة وفق المستوي التعليمي على مقياس الوصمة الاجتماعية المدركة، بالإضافة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في جودة الحياة الأسرية وفقاً للمستوى التعليمي. كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة وفقاً لنوع الإعاقة على مقاييس كلٍّ من التحيزات المعرفية والوصمة الاجتماعية المدركة وجودة الحياة الأسرية.

و دراسة عبدالعال (٢٠٢١) فقد توصلت إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي لحالات المجموعتين الضابطة

والتجريبية على مقياس الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون، ولا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي لحالات المجموعة الضابطة على مقياس الوصمة لدى أمهات متلازمة داون، وتوجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي لحالات المجموعة التجريبية على مقياس الوصمة الاجتماعية لدى أمهات متلازمة داون لصالح القياس البعدي.

ودراسة متولي (٢٠٢٠) فقد توصلت إلى تحسين درجة التوجه نحو الحياة، وأيضاً خفض درجة الشعور بالوصمة الاجتماعية لدى الأمهات، وقد امتد تأثير البرنامج لما بعد التطبيق بشهرين، والاستفادة من البرنامج الإرشادي في تحسين مستوى الصحة النفسية لديهن من خلال التخلص من معاناتهم.

ودراسة بدارنة (٢٠١٩) فقد توصلت إلى أن تصورات أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد جاء بدرجة ضمن المستوى المتوسط. وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بالتدخل الإرشادي المبكر للتخفيف من الآثار النفسية لوجود طفل ذوي اضطراب طيف التوحد في العائلة.

أما دراسة السيد (٢٠١٨) فقد توصلت إلى عدم تأثير الوصمة بعمر الأم، يؤثر كل من المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي على شعور الأم بالوصمة، كما كشفت النتائج أن العزلة الاجتماعية، انخفاض تقدير الذات، نقص المساندة الاجتماعية، المشاعر السلبية من المحددات الرئيسية للوصمة لدى أفراد عين الدراسة من أمهات الأطفال من ذوي متلازمة داون.

بينما دراسة مرسي (٢٠١٨) فقد توصلت إلى فعالية البرنامج القائم على إستراتيجية التقليد في تحسين حالة الأطفال ذوي اضطراب التوحد وخفض الوصمة الاجتماعية والضغط النفسية لدى الأمهات.

ودراسة (Werner & Shulman 2015) فقد توصلت إلى أن مستوى التوجهات السلبية المتعلقة بالوصمة الاجتماعية للإعاقة لدى أسر الأطفال ذوي الإعاقات الفكرية كانت بنسبة (٢٢،٤ %) بينما كانت لدى أطفال ذوي الإعاقات الخلقية أو الجسدية بنسبة (٢٧،١ %)، بينما وصلت النسبة بين أسر أطفال ذوي متلازمة داون (٩،٣٢ %) ومن هنا استنتج البحث ارتفاع مستوى التوجهات السلبية المتعلقة بالوصمة الاجتماعية للإعاقة لدى أسر الأطفال ذوي متلازمة داون بالمقارنة بين المجموعتين الآخرين من أسر أطفال ذوي الإعاقة الفكرية، وأسرة الأطفال ذوي الإعاقات البدنية.

ودراسة الرياحنة (٢٠١٥) فقد توصلت إلى وجود فرق دال إحصائياً بين التوافق الأسري لدى أسر أطفال متلازمة داون يُعزى لمتغير (عمر الأم وعمر الطفل).

بينما دراسة (Werner & Shulman, 2013) فقد توصلت إلى انخفاض معدل الشعور بالرفاهية الذاتية لدى عينة البحث عن متوسط المستوى الطبيعي، خاصة بالنسبة لأسر أطفال طيف الذاتوية مقارنة بباقي الإعاقات، كما توصلت النتائج إلى وجود ارتباط سالب ودال بين الوصمة والرفاهية الذاتية لدى عينة أمهات طيف الذاتوية في حين لم يتضح هذا الارتباط لدى باقي عينات البحث.

ودراسة (Hemmati, Solemani, Seyednour, & Dadkhah, 2010): فقد توصلت إلى أن هناك أثراً سلبياً للوصمة الاجتماعية على أفراد الأسرة، وكذلك أشارت النتائج إلى أن أطفال متلازمة داون لديهم وصمة اجتماعية منذ الولادة. أما دراسة (Dehnavi m Nouri, Jafari, & Faramarzi, 2008) فقد توصلت إلى وجود وصمة لدى أمهات أطفال متلازمة داون، كما أظهرت النتائج أن عمر الأم أفضل مؤشر في وصم الأم.

المحور الثالث: الدراسات التي تناولت الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية: دراسة إبراهيم (٢٠٢٣) فقد توصلت إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي لمجموعة البحث في تحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم لصالح القياس البعدي، وهذا التحسن يرجع إلى أن برنامج الألعاب الترويحية ذو تأثير إيجابي في تحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم،

بينما دراسة عبد اللاه وسليمان وعبدالله (٢٠٢٣) فقد توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) بين متوسطات درجات كلٍّ من الآباء والأمهات في الوصمة المدركة في اتجاه الأمهات، كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) بين متوسطات درجات كلٍّ من الآباء والأمهات في الشفقة بالذات لصالح الآباء.

أما دراسة أبو بكر (٢٠٢٢) فقد توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الوصمة الاجتماعية والشفقة بالذات، بينما كانت العلاقة موجبة دالة إحصائياً بين الشفقة بالذات وبين الوالدية اليقظة عقلياً، وكانت العلاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين الوصمة الاجتماعية والوالدية اليقظة عقلياً.

بينما دراسة سيد (٢٠٢١) فقد توصلت إلى فعالية برنامج الإرشاد المعرفي القائم على اليقظة العقلية في تحسين الشفقة بالذات وأثره في خفض وصمة الذات لدى طلاب جامعة المنيا المعاقين حركياً، كما أشارت درجاتهم في القياس البعدي والتتبعي.

ودراسة (Wong, Mak, & Liao, 2017) فقد توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشعور بالوصمة وكلٍّ من الفلق والاكتئاب، ووجود علاقة

ارتباطية بين الشعور بالوصمة وكلّ من الشفقة بالذات تتوسّط العلاقة بين الشعور بالوصمة والقلق والاكتئاب، وأن منخفضي الشفقة بالذات من الآباء والأمهات لديهم مستويات مرتفعة من الشعور بالوصمة مقارنة بمرتفعي الشفقة بالذات، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشفقة بالذات والمساندة التي يتلقاها أفراد عينة الدراسة، سواء من الأصدقاء أو من المحيطين بهم.

التعليق على الدراسات السابقة:

يُلاحظ من عرض الدراسات السابقة أن:

- بعض الدراسات تناولت البحث عن مستوى الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، والتعرّف على الفروق في الشفقة بالذات بين الآباء والأمهات كدراسة السمحة (٢٠٢٠). بينما هدفت بعض الدراسات الأخرى إلى التعرف على العلاقة بين الشفقة بالذات والاكتئاب مثل دراسة مختار ومحمد (٢٠١٩)، والبعض الآخر هدف إلى التعرف على العلاقة بين الشفقة بالذات وكلّ من الصمود النفسي مثل دراسة رضوان (٢٠١٩). في حين هدفت دراسة أبو حشيش (٢٠٢٢) إلى تحسين الشفقة بالذات لدى أمهات اضطراب التوحد، كما هدفت دراسة إبراهيم (٢٠٢٣) إلى تحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية وقلق المستقبل.

- من حيث العينة: تشير معظم الدراسات إلى استهداف أمهات ذوي الإعاقة العقلية كعينة كما في دراسة كلّ من مختار ومحمد (٢٠١٧) وجوهر (٢٠٢١) ودراسة أيدن (٢٠١٥)، ودراسة عبداللاه سليمان وعبدالله (٢٠٢٣) ودراسة محمد (٢٠١٨)، وأخرى استهدفت أمهات أطفال التوحد كعينة دراسة أبو حشيش (٢٠٢٢) والسمحة (٢٠٢٠) وأبو بكر (٢٠٢٢) ودراسة Wong, Mak, & Liao (2016)، وبعض الدراسات تضمّنت عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم كعينة دراسة إبراهيم (٢٠٢٣)، وبعضها تضمّنت عينة من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة كعينة دراسة رضوان (٢٠١٩)، والبعض الآخر تضمن عينة عشوائية من الأمهات والآباء كعينة Kristina (2017). وعينة (2017) Arnos الذين يعانون من اضطراب التواصل.

- أما من حيث منهج الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي الارتباطي مثل دراسة محمد (٢٠١٨) ودراسة كريستينا (٢٠١٧) ودراسة أيدن (٢٠١٥) ودراسة عيسى (٢٠٢٣)، ودراسة Arnos (2017). واختلفت من حيث المنهج مع دراسة كلّ من السيد (٢٠٢١) ودراسة محمد (٢٠٢١) ودراسة Werner & Shulman (2015) حيث إنهم استخدموا المنهج الوصفي المقارن، كما كان المنهج شبه التجريبي من نصيب دراسة متولي (٢٠٢٠) ودراسة عبدالعال (٢٠٢١).

- من حيث أدوات الدراسة فقد استخدمت معظم الدراسات الاستبانة كأداة لجمع البيانات. ولكن لوحظ فيها اختلاف المقاييس، فبعض الدراسات استخدمت مقياس الشفقة بالذات من إعداد الباحث مثل دراسة السمحة (٢٠٢٠) ودراسة رضوان (٢٠١٩)، والبعض منها استخدم مقاييس معدة مسبقاً كمقياس الشفقة بالذات من إعداد نيف (٢٠٠٣) مثل دراسة كلٍّ من جوهر (٢٠٢١)، ودراسة أبو حشيش (٢٠٢٢)، ودراسة أيدن (٢٠١٥)، ودراسة عيسى (٢٠٢٣)، ودراسة محمد (٢٠١٨)، ودراسة (Arnos, 2017)، ودراسة Kristina (2017) .. ومقياس الشفقة بالذات إعداد عبد الرحمن وزملائه (٢٠١٥) في دراسة مختار ومحمد (٢٠١٧). كذلك بالنسبة للوصمة الاجتماعية فقد تناولت بعض الدراسات مقياس الوصمة من إعداد الباحث مثل دراسة أبو بكر (٢٠٢٢)، ودراسة عبداللاه وسليمان وعبدالله (٢٠٢٣)، ودراسة السيد (٢٠١٨). مقياس السيد (٢٠١٨) في دراسة محمد (٢٠٢١)، ومقياس الحسون (٢٠١٣) في دراسة الرياحنة (٢٠١٥)، ومقياس (Mak & Chung, 2008) في دراسة وريزر وشيلمان (٢٠١٣)، ومقياس البلاح (٢٠١٨) في دراسة إبراهيم (٢٠٢٣). أما في الدراسة الحالية فقد ارتأت الباحثة استخدام مقياس الشفقة بالذات من إعداد نيف (Neff, 2003) ومقياس الوصمة الاجتماعية من إعداد الرياحنة (٢٠١٥) لتوافقها مع عينة الدراسة وأهدافها.
- وتوصّلت بعض نتائج الدراسات إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشفقة بالذات وبعض المتغيرات مثل دراسة محمد (٢٠١٨)، ورضوان (٢٠١٩) وعيسى (٢٠٢٣)، كما توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الشفقة بالذات وبعض المتغيرات مثل دراسة جوهر (٢٠٢١)، ودراسة مختار ومحمد (٢٠١٧). وتوصل البعض الآخر إلى وجود علاقة دالة إحصائية بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية مثل دراسة إبراهيم (٢٠٢٣)، ودراسة عبداللاه وسليمان وعبدالله (٢٠٢٣). بينما أسفرت دراسة السيد (٢٠٢١) عن فاعلية البرنامج الإرشادي المعرفي في تحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية، ولم تجد الباحثة في حدود اطلاعها على الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة، دراسة تناولت الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية وجاءت نتيجتها لا توجد علاقة دالة إحصائية.
- إجمالاً يمكن القول إن مختلف الدراسات التي تمّ عرضها كانت تصبُّ في السياق نفسه الذي صبت فيه هذه الدراسة من الناحية النظرية من حيث تناولها لمتغيري الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية كما اتفقت معظم الدراسات على الأبعاد المكونة لمتغيرات البحث، فبالنسبة للشفقة بالذات تتكوّن من ثلاثة أبعاد هي: (اللفظ بالذات - الإنسانية المشتركة - اليقظة العقلية) في حين تتكوّن الوصمة الاجتماعية من (الموصوم - مركب الموصوم السوي - طبيعة العمليات الوصمية).

منهجية البحث:

بما أن هدف البحث هو التعرف على الشفقة بالذات وعلاقتها بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام، فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، ويُقصد به ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطته معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين متغيرين أو أكثر، ومن ثم معرفة درجة تلك العلاقة.

مجتمع الدراسة:

يتكوّن مجتمع البحث من ١٥٠ أم من مهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام.

العينة الاستطلاعية:

الهدف من العينة الاستطلاعية هو التحقق من صلاحية الأدوات التي يمكن استخدامها في دراسة العينة من حيث وضوح عباراتها وسلامة تعليماتها ودراسة خصائصها السيكومترية. وتمّ تطبيق أدوات البحث على عينة استطلاعية تكوّنت من (٣٠) من أمهات أطفال متلازمة داون.

عينة الدراسة:

يتكوّن مجتمع البحث من جميع أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام، وقد تكوّنت عينة البحث من (١٥٠) من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام وقد تمّ اختيار عينة البحث بالطريقة الحصر الشامل ومن أهم خصائص أفراد عينة البحث هي:

١- العمر

وبالنسبة للعمر فقد تبين أن ما نسبته (٣٧.٣٪) من إجمالي أفراد البحث من أمهات أطفال متلازمة داون عمرهن (من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة)، في حين وجد أن ما نسبته (٢٧.٣٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات عمرهن (من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة)، في حين وجد أن ما نسبته (١٦.٧٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات عمرهن (من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة)، في حين وجد أن ما نسبته (١٢.٠٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات عمرهن (٦٠ سنة فأكثر)، في حين وجد أن ما نسبته (٦.٧٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات عمرهن (أقل من ٣٠ سنة).

٢- المستوى التعليمي:

وبالنسبة للمستوى التعليمي فقد تبين أن (٤٨٪) من إجمالي أفراد البحث من أمهات أطفال متلازمة داون مستواهن التعليمي (ثانوية عامة فما دون)، في حين وجد أن (٤٠.٧٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات مستواهن التعليمي (بكالوريوس فأعلى)، بينما في حين وجد أن (١١.٣٪) من إجمالي أفراد البحث من الأمهات مستواهن التعليمي (أمي).

أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف البحث تمّ استخدام المقاييس التالية:

أولاً: مقياس الشفقة بالذات إعداد نيف 2003, Neff ترجمة: (علام، ٢٠١٧).

١ - وصف المقياس وطريقة تصحيح المقياس:

وضعت (2003) Neff (٢٦) بنذاً مؤرّعة على الأبعاد الستة للمقياس، كما تضمّنت البنود الجوانب الإيجابية والسلبية في كل بُعد من هذه الأبعاد، ويُجاب عن المقياس من خلال مدرج خماسي يتكوّن من (٥) درجات، وفقاً لتدريج (Likert) الخماسي: وهي موافق بشدة، وأعطيت لها (٥) درجات، موافق، وأعطيت لها (٤) درجات، ومحايد وأعطيت لها (٣) درجات، غير موافق، وأعطيت لها درجتان، غير موافق بشدة، وأعطيت لها درجة واحدة، وهذه للعبارات الإيجابية، وتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة، وبما أن المقياس تكوّن بصورته النهائية من (٢٦) فقرة، فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب (١٣٠) درجة وأدنى درجة هي (٢٦). وتشير الدرجة المرتفعة إلى أن الفرد رحيم بذاته عندما يمر بخبرات مؤلمة ومعاناة، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى أن الفرد أكثر قسوة على ذاته في المحن والمواقف الصعبة.

ملاحظة: عند التعامل مع الأبعاد الفرعية تكون كل العبارات موجبة الاتجاه، لكن في حالة التعامل مع الدرجة الكلية يتمّ تصحيح عبارات الأبعاد رقم (٢-٤-٦) بطريقة عكسية.

وأصبح المقياس في الصورة الحالية مكوناً من (٢٦) فقرة مؤرّعة على ٦ أبعاد ويتضح توزيعها من خلال الجدول (١) التالي:

جدول (١) توزيع فقرات مقياس الشفقة بالذات على أبعاده

الأبعاد	عدد العبارات	العبارات
الرحمة بالذات	٥	٢٦-٢٣-١٩-١٢-٥
الحكم الذاتي	٥	٢١-١٦-١١-٨-١
الإنسانية العامة	٤	١٥-١٠-٧-٣
العزلة	٤	٢٥-١٨-١٣-٤
البقطة العقلية	٤	٢٢-١٧-١٤-٩
الإفراط في التوحد	٤	٢٤-٢٠-٦-٢
مجموع العبارات	٢٦	

٣ - معيار الحكم على مستويات مقاييس الشفقة بالذات لدى عينة البحث

حيث إن:

أقل درجة في مقياس الشفقة بالذات هي ٢٦ وأعلى درجة في مقياس الشفقة بالذات هي ١٣٠

نقوم بطرح (١٣٠-٢٦) = ١٠٤ ولكي نقوم بتقسيم إلى خمس فئات نقسم على ٥
 $104/5 = 20.8$ تقريباً إذن مدى الفئات ٢٠ تقريباً
 وللتعرف على مستويات الشفقة بالذات لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة
 داون، كما هو موضح بالجدول التالي:
 جدول رقم (٢) معايير وصف مستويات الشفقة بالذات لدى عينة البحث من أمهات
 أطفال متلازمة داون

المستوى	مدى القيم بالدرجات الخام
متدنية جداً	من ٢٦ إلى ٤٦
متدنية	من ٤٧ إلى ٦٧
متوسطة	من ٦٨ إلى ٨٨
مرتفعة	من ٨٩ إلى ١٠٩
مرتفعة جداً	من ١١٠ إلى ١٣٠

الخصائص السيكومترية لمقياس الشفقة بالذات:

١ - الخصائص السيكومترية لمقياس الشفقة بالذات في صورته الأصلية
 تحققت نيف من صدق المقياس وثباته بعدة طرائق في سياق العديد من الدراسات
 والتي اشتملت على عينة مختلفة في عدة دول أوروبية، (Neff.et.al، 2008)،
 (Neff، 2003)، وكشفت نتائج الدراسات عن تمتع المقياس بمؤشرات صدق وثبات
 جيدة فقد حسب الصدق بأكثر من طريقة منها الاتساق الداخلي، الصدق التكويني،
 والصدق التنبؤي، والتي أشارت جميعها إلى مؤشرات صدق مرتفعة، أما الثبات
 فحسب بطريقة إعادة التطبيق وحقت معاملات ارتباط مرتفعة بين التطبيقين وأكدت
 صلاحيته للاستخدام.

وقد تبين أن مقياس الشفقة بالذات يتمتع بدرجة عالية من الصدق حيث تبين
 أن عبارات مقياس الشفقة بالذات تتسق اتساقاً مرتفعاً مع الدرجة الكلية للمقياس وأن
 جميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى (٠.٠١)، وأن مقياس الشفقة بالذات يتمتع
 بنسبة ثبات مرتفعة، حيث تراوحت قيم الثبات المحسوبة بطريقتي سبيرمان براون
 وجتمان بين (٠.٥٩ - ٠.٧٥).

ثانياً: مقياس الوصمة الاجتماعية إعداد (الرياحنة، ٢٠١٥).

أ- وصف المقياس:

قام الرياحنة بإعداد مقياس الوصمة الاجتماعية (٢٠١٥) بعد الاطلاع على
 الادب النظري للوصمة الاجتماعية لحسون (٢٠١٣). تم إعادة صياغة فقرات
 المقياس حيث تم التوصل لمقياس مكون من (٢٣) فقرة في صورته الأولية، للتحقق
 من الصدق الظاهري للمقياس وأبعاده، تم عرض المقياس على مجموعة من
 المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإرشاد النفسي وعلم النفس

التربوي والتربية الخاصة والمناهج في جامعة اليرموك، وكان المعيار الذي تمّ اعتماده في قبول الفقرات أو تباعدها، هو حصول الفقرة الواحدة على نسبة موافقة ٨٠ % من المحكمين للإبقاء عليها، وبذلك أصبح عدد فقرات المقياس في صورتها النهائية بعد التحكيم (٢٢) فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد: البعد النفسي، والبعد الاجتماعي، والبعد التمييزي.

ب- طريقة تصحيح المقياس:

تكوّن مقياس الوصمة الاجتماعية بصورته النهائية من (٢٢) عبارة موزعة على (٣) أبعاد، يُجاب عن المقياس من خلال مدرج خماسي يتكوّن من (٥) درجات، وفقاً لتدريج ليكرت (Likert) الخماسي: وهي موافق بشدة، وأعطيت لها (٥) درجات، موافق، وأعطيت لها (٤) درجات، ومحايد وأعطيت لها (٣) درجات، غير موافق، وأعطيت لها درجتان، غير موافق بشدة، وأعطيت لها درجة واحدة، وهذه للعبارات الإيجابية، وتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة وهي الفقرات أرقام (٢٠-٢٢)، إذ تعطى موافق بشدة (١) درجة، موافق تعطى لها (٢) درجات، ومحايد وتعطى لها (٣) درجات، وغير موافق وتعطى لها (٤) درجات، غير موافق بشدة وتعطى لها (٥) درجات. وبناءً على ذلك فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة بين درجة واحدة، وخمس درجات، وبما أن المقياس تكوّن بصورته النهائية من (٢٢) فقرة، فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب (١١٠) درجات وأدنى درجة هي (٢٢)، وأصبح المقياس في الصورة الحالية مكوناً من (٢٢) فقرة موزعة على ٣ أبعاد ويتضح توزيعها من خلال الجدول (٣) التالي:

جدول (٣) توزيع فقرات مقياس الوصمة الاجتماعية على أبعاده

الأبعاد	عدد العبارات	العبارات
البعد النفسي	٧	٢٢-٦-٥-٤-٣-٢-١
البعد الاجتماعي	٧	٢٠-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٨-٧
البعد التمييزي	٨	٢١-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥-١٤
مجموع العبارات		٢٢

معيار الحكم على مستويات مقياس الوصمة الاجتماعية لدى عينة البحث وحيث إن:

أقل درجة في مقياس الوصمة الاجتماعية هي ٢٢ وأعلى درجة في مقياس الوصمة الاجتماعية هي ١١٠

نقوم بطرح (٢٢-١١٠) = ٨٨ ولكي نقوم بالتقسيم إلى خمس فئات نقسم على ٥

٨٨/٥ = ١٧ تقريباً إذن مدى الفئات ١٧ تقريباً

وللتعرّف على مستويات الوصمة الاجتماعية لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم (٤) معايير وصف مستويات الوصمة الاجتماعية لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون

المستوى	مدى القيم بالدرجات الخام
متدنية جدًا	من ٢٢ إلى ٣٩
متدنية	من ٤٠ إلى ٥٧
متوسطة	من ٥٨ إلى ٧٥
مرتفعة	من ٧٦ إلى ٩٣
مرتفعة جدًا	من ٩٤ إلى ١١٠

الخصائص السيكومترية لمقياس الوصمة الاجتماعية:

١- الخصائص السيكومترية لمقياس الوصمة الاجتماعية في صورته الأصلية وبهدف التحقق من صدق البناء مقياس الوصمة الاجتماعية، تم تطبيق مقياس الوصمة الاجتماعية على عينة استطلاعية تكوّنت من ٧ أسر من أسر أطفال متلازمة داون من خارج عينة البحث المستهدفة؛ وذلك لحساب معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات الأداة وبين أداة البحث والأبعاد التي تتبع لها.

وقد تبين أن قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠٥)، (٠.٠١)، وتراوحت قيم معامل ارتباط فقرات البعد النفسي ما بين (٠.٤٣ - ٠.٨٠) مع بعدها، وأن قيم معاملات ارتباط فقرات البعد الاجتماعي قد تراوحت بين (٠.٤٠ - ٠.٨٣) مع بعدها، وقد اتضح أن قيم معاملات الارتباط بين فقرات بعد التميز الاجتماعي والبعد نفسه تراوحت بين (٠.٣٠ - ٠.٨١).

وقد اتضح أن قيم معاملات الارتباط لأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية مع الدرجة الكلية للمقياس قد تراوحت ما بين (٠.٧٩ - ٠.٩٤)؛ ما يشير أن الاتساق الداخلي لمقياس جودة الوصمة الاجتماعية مرتفع، وأيضاً يشير إلى جودة بناء فقرات مقياس الوصمة الاجتماعية.

وقد تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وقد تبين أن معاملات الثبات لأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية تراوحت ما بين (٠.٧٩ : ٠.٩٠)، في حين بلغ معامل الثبات للمقياس ككل (٠.٩٣) وجميعها معاملات ثبات مقبولة إحصائياً؛ ما يشير إلى الثقة في النتائج التي يمكن التوصل إليها من تطبيق مقياس الوصمة الاجتماعية.

٢- صدق مقياس الوصمة الاجتماعية:

قامت الباحثة بتقدير صدق مقياس الوصمة الاجتماعية في دراستها الحالية باستخدام صدق الاتساق الداخلي أو صدق البناء الداخلي للمقياس:

أ- حساب قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس الوصمة

الاجتماعية والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وجاءت النتائج موضحة أن جميع معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس الوصمة الاجتماعية والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة جميعها دالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) حيث تراوحت معاملات الارتباط ما بين (٠.٤١٨) و(٠.٧٨٠)؛ ما يعكس درجة عالية من صدق البناء لأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية، وهذه النتيجة تشير إلى إمكانية استخدام مقياس الوصمة الاجتماعية في البحث الحالية وصلاحيته للتطبيق الميداني.

ب- حساب معاملات الارتباط بين مجموع درجات كل بُعد من الأبعاد الرئيسية والدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية كما يوضحه جدول رقم (٤) وجميع قيم معاملات الارتباط بين درجة كل بُعد من الأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية والدرجة الكلية للمقياس تتراوح ما بين (٠.٧٥٥) و(٠.٨٩٢) وجميعها موجبة ودالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١)؛ ما يعكس درجة عالية من صدق البناء لأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية، وهذه النتيجة تشير إلى إمكانية استخدام مقياس الوصمة الاجتماعية في البحث الحالية وصلاحيته للتطبيق الميداني.

ج- الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية) لمقياس الوصمة الاجتماعية وأبعاده:

قامت الباحثة بحساب صدق المجموعات المتضادة (الطرفية) وهي تشير إلى قدرة المقياس على التمييز بين المجموعات مرتفعي ومنخفضي الدرجة، حيث يتم ترتيب درجات أفراد العينة تنازلياً أو تصاعدياً، ثم نقوم بتحديد الأرباعي الأعلى والأرباعي الأدنى، ويتم المقارنة بين متوسطي الأرباعي الأعلى والأدنى وحساب دلالة الفروق بين المتوسطات، وتوضح النتائج أن القيم التائية المحسوبة لجميع أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية والدرجة الكلية كانت دالة وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية ومستوى الدلالة (٠.٠١) دالة عند مستوى (٠.٠٥) فأقل، وأن هناك فرقاً بين الأرباعي الأدنى والأرباعي الأعلى؛ ما يُبين أنها تتمتع بالقدرة على التمييز بين المجموعتين الدنيا والعليا، وهذا دليل على تمثُّع مقياس الوصمة الاجتماعية بصدق تمييزي عالٍ يمكن الاعتماد عليه في التطبيق النهائي.

٣- ثبات مقياس الوصمة الاجتماعية:

للتحقُّق من ثبات مقياس الوصمة الاجتماعية تمَّ حسابه بطريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية، وفيما يلي النتائج الإحصائية الدالة على ذلك: واتضح أنه من خلال طريقة التجزئة النصفية فقد بلغ معامل ثبات النصف الأول للمقياس (٠.٨٣٦)، وبلغت قيمة معامل ثبات النصف الثاني للمقياس (٠.٦١٨)، وباستخدام معادلة سبيرمان-براون للحصول على القيمة المصححة لمعامل ثبات، فإن معامل الثبات بلغ بعد التصحيح (٠.٧٢١)، وجميعها معاملات ثبات مرتفعة؛ ما يدلُّ على أن مقياس الوصمة الاجتماعية يتمثُّع بدرجة عالية من الثبات، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا

كرونباخ لمقياس الوصمة الاجتماعية بلغت (٠.٨٢٩)؛ ما يدلُّ على أن مقياس الوصمة الاجتماعية يتمتّع بدرجة عالية من الثبات، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة.

الأساليب الإحصائية:

اعتمدت الباحثة الأساليب الإحصائية من ناحية إعداد أداة البحث أو تحليل النتائج على البرنامج الإحصائي SPSS واستخدمت الوسائل الإحصائية التالية:

- التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد عينة البحث وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المقاييس التي تتضمنها أداة الدراسة.

- معامل ارتباط بيرسون لحساب العلاقة بين كلٍّ من:

- درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.

- لاستخراج العلاقات الارتباطية بين كلٍّ من الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون.

- طريقة التجزئة النصفية لحساب الثبات.

- معادلة سبيرمان براون التصحيحية لتصحيح معامل الارتباط للمقياس عند حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.

- معامل ألفا كرونباخ لاستخراج ثبات المقاييس.

- حساب المتوسطات والانحرافات والوزن النسبي لكل بُعد من أبعاد المقاييس والدرجة الكلية لكل مقياس.

- اختبار تحليل التباين الأحادي (One-Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة

الإحصائية في الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر).

نتائج البحث :

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول: ما مستوى الشفقة بالذات لدى

أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟

للإجابة عن هذا السؤال تمّ صياغة الفرضية التالية:

"تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى منخفض من الشفقة بالذات"

وللإجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة الفرضية السابقة تمّ حساب

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية وقيمة "ت" لكل بُعد

من أبعاد مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات؛ وذلك كما هو

مبين في الجدول التالي:

جدول رقم (٥) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية وقيمة "ت" لكل بُعد من أبعاد مقياس الشفقة بالذات والدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات لدى عينة الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام وكذلك ترتيبها

م	أبعاد مقياس الشفقة بالذات	عدد العبارات	الدرجة الكلية للبعد	المتوسط الفرضي	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي*	القيمة التائية	مستوى الدلالة	الترتيب
١	الرحمة بالذات	٥	٢٥	١٥	١٧.١٥	٣.٠٠	٦٨.٦٠	٨.٨٠	٠.٠١	٣
٢	الحكم الذاتي	٥	٢٥	١٥	١٥.٥٥	٢.٩٨	٦٢.٢٠	٢.٢٧	٠.٠٢	٦
٣	الإنسانية العامة	٤	٢٠	١٢	١٦.٢١	٢.٦١	٨١.٠٥	١٩.٧٢	٠.٠١	١
٤	العزلة	٤	٢٠	١٢	١٠.٤٥	٣.٠٤	٥٢.٢٥	٦.٢٤	٠.٠١	٤
٥	اليقظة العقلية	٤	٢٠	١٢	١٤.٩٠	٢.٢٢	٧٤.٥٠	١٦.٠١	٠.٠١	٢
٦	الإفراط في التوحد	٤	٢٠	١٢	١١.٦٩	٣.٠٢	٥٨.٤٥	١.٢٧	٠.٢١	٥
	الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات	٢٦	١٣٠	٧٨	٨٥.٩٥	١٠.٤١	٦٦.١٢	١٢.٤٤	٠.٠١	

* يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بُعد على الدرجة الكلية للبعد ثم ضرب الناتج في 100

يتضح من الجدول رقم (٥) أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) فأقل بين المتوسطات الحقيقية للدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات بأبعاده (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة، اليقظة العقلية) من جهة والمتوسطات الافتراضية من جهة أخرى، وكانت هذه الفروق لصالح المتوسطات الحقيقية لعينة الدراسة في أبعاد (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة، اليقظة العقلية)، والتي كانت أعلى من المتوسطات الافتراضية؛ ما يُبين ارتفاع مستوى الشفقة بالذات بأبعاده (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة، اليقظة العقلية) لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام.

في حين فيما يتعلّق ببُعد الإفراط في التوحد فلم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحقيقي لهذا البُعد من جهة والمتوسط الافتراضي من جهة أخرى.

وقد وُجد أن متوسط درجات الشفقة بالذات يساوي (٨٥.٩٥ من ١٣٠) وبوزن نسبي (٦٦.١٢ %)، وحيث إنه حسب المحك المذكور سابقاً في جدول (٥) بأنه إذا بلغ مستوى الشفقة بالذات من ٦٨ إلى ٨٨ فإن ذلك يعد مستوى متوسطاً من الشفقة بالذات؛ لذلك فإن مستوى الشفقة بالذات لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام يوجد بدرجة متوسطة. وبالتالي لم تتحقّق صحة الفرضية التي نصّها: "تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى منخفض من الشفقة بالذات"

ولقد توصل البحث الحالي إلى النتيجة التالية: تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى متوسط من الشفقة بالذات. اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة السمحة (٢٠٢٠) والتي جاءت بنتيجتها أن مستوى الشفقة بالذات متوسط لدى آباء وأمّهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى جاء مستوى الشفقة بالذات لدى الآباء مرتفعاً (موجب) مثل دراسة عيسى (٢٠٢٣). ودراسة رضوان (٢٠١٩). ودراسة محمد (٢٠١٨) ودراسة Arnos (2017) والتي كانت عينتها آباء وأمّهات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل، وأيضاً اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي جاءت الشفقة بالذات لديها منخفضة مثل دراسة جوهر (٢٠٢١). ودراسة رضوان (٢٠١٩). ودراسة مختار ومحمد (٢٠١٧).

وتؤكد هذه النتيجة ما أشار إليه سليم وأبو حلاوة (٢٠١٨) من أن الأشخاص ذوي المستوى المرتفع من الشفقة بالذات يتميّزون باعتبارهم للإخفاق في حياتهم على أنها أمر عادي في دنيا البشر، ويتعاملون معها بصورة هادئة ومتزنة، كما أنهم لا يشعرون بالاستياء إلى ذواتهم بسبب أوجه القصور التي لديهم. وأكد (neff 2006) الشفقة بالذات بأنها اتجاه إيجابي نحو الذات في المواقف المؤلمة أو في مواقف الفشل ينطوي على اللطف بالذات وعلى عدم الانتقاد الشديد لها، وفهمها كجزء من الخبرات التي يعانيتها أغلب الناس ومعالجة المشاعر المؤلمة بوعي وب عقل منفتح.

كما تبين نتائج الأبعاد الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون جاء في المرتبة الأولى بعد الإنسانية العامة (المشتركة) حيث ترجع الباحثة السبب إلى الاهتمام بالأمّهات بوحدة الخدمات الاجتماعية بالدمام، وعمل دورات تدريبية وورش ومناقشات مفتوحة وكتيبات ونشرات تثقيفية عن طريقة التعامل مع أطفالهن ومع

المجتمع؛ ما أدّى إلى وضوح الصورة لديهن، وتبادل المعلومات والنقاشات بين الأمهات، يؤدي إلى تحسين الشفقة بالذات ودعم الإنسانية المشتركة لديهن .

أما فيما يتعلّق ببعد اليقظة العقلية فجاء بمستوى مرتفع لدى أمهات أطفال متلازمة داون، وترى الباحثة أن هذه النتيجة ترجع إلى اهتمام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالأم؛ لأنها أقرب شخص للطفل، ووعيتها هو العامل الأول والرئيسي في علاج الطفل، ويتمّ تثقيف الأمهات بمعلومات علمية ودقيقة عن مرض أطفالهن وتدريبهن على استخدام العقل أكثر من العاطفة في التعامل مع الطفل، وتدريبهن على أنواع التأمل الذي يركّز على الانتباه القوي لما تحسه وتشعر به .

وأيضًا فيما يتعلّق ببعد الرحمة بالذات فأيضًا جاء بمستوى مرتفع لدى الأمهات أطفال متلازمة داون، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن وعي الأمهات العالي بأهمية الرفق بأنفسهن يساعدهن على التحمل والتقبّل لما يمررن به من متاعب الحياة، وإدراكهن بأهمية العطف والحنان على أنفسهن في الظروف الصعبة التي يمررن بها؛ لأن ذلك ينعكس على أطفالهن من ناحية التعامل والحب والحنان والتحمّل، وأن الرحمة بالذات تؤدي إلى ارتفاع الثقة بالذات وتقبّل متاعب الحياة اليومية .

أما بُعد الحكم الذاتي لدى أمهات أطفال متلازمة داون فجاء بمستوى متوسط، وترجع الباحثة ذلك إلى وعي الأمهات بالمسؤولية نحو أطفالهن؛ لذلك يشفقن على أنفسهن ولا يقسون عليها؛ لأنهن يعلمن أنهن يتحملن كثيرًا، وعليهن مساعدة أنفسهن لكي يستطعن مساعدة أطفالهن؛ لأنهم بحاجة لأمهاتهم أكثر من أي شخص آخر. وجاء بُعد الإفراط في التوحد لدى أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى متوسط، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وعي الأمهات بذاتهن وأطفالهن والتقبّل والانفتاح على العديد من طرق العلاج والتعامل مع أطفال متلازمة داون؛ ما أدّى إلى مواجهة الأمور كما هي، وعدم تهويلها، وعدم الانسياق وراء المشاعر السلبية، وبيحثن عن أسباب من حولهن تؤدي إلى رفع روحهن المعنوية.

أما بُعد العزلة فجاء أقل أبعاد الشفقة بالذات بالنسبة لأمهات أطفال متلازمة داون بمستوى متوسط، وتفسر الباحثة هذه النتيجة هو تحسن الأطفال ذوي متلازمة داون بالوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة؛ ما أدّى إلى تحسين الصحة النفسية للطفل، وبناء ثقته بنفسه، وانعكس ذلك على الصحة النفسية للأمهات وبناء الثقة بالنفس لديهن مع أنفسهن ومع الآخرين، والخروج من المخاوف، وعمل علاقات عائلية واجتماعية، والمشاركة في الأنشطة .

وفي ضوء النتائج السابقة ترى الباحثة أن الشفقة بالذات بالرغم من أنه مصطلح حديث إلا أنه أحد المكونات الأساسية والمعرفية؛ ولذلك نجد أن أمهات أطفال متلازمة داون يتمتعن بدرجة متوسطة من الشفقة بالذات لديهن؛ ما ساعد على

الحفاظ على تماسكهن، والمعايشة مع الخبرة الذاتية والمؤلمة ببقطة عقلية عالية دون الاستسلام الانفعالات السلبية لديهن.

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: ما مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟ للإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

"تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى مرتفع من الوصمة الاجتماعية" وللإجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة الفرضية السابقة تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية وقيمة "ت" لكل بُعد من أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية والدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية؛ وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم (٦) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية وقيمة "ت" لكل بُعد من أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية والدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية لدى عينة الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام وكذلك ترتيبها

م	أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية	عدد العبارات	الدرجة الكلية للبعد	المتوسط الفرضي	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي*	القيمة التائية	مستوى الدلالة	الترتيب
١	البعد النفسي	٧	٣٥	٢١	١٦.٨١	٣.٧١	٤٨.٠٣	١٣.٨٣	٠.٠١	٣
٢	البعد الاجتماعي	٨	٤٠	٢٤	٢٦.٠٢	٥.٢٠	٦٥.٠٥	٤.٧٦	٠.٠١	٢
٣	البعد التمييزي	٧	٣٥	٢١	٢٤.١٠	٣.٩٠	٦٨.٨٦	٩.٧٢	٠.٠١	١
	الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية	٢٢	١١٠	٦٦	٦٦.٩٣	١٠.٣٩	٦٠.٨٥	١.٠٩	٠.٢٨	

*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية للبعد ثم ضرب الناتج في 100

يتضح من الجدول رقم (٦) أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠.٠١) فأقل بين المتوسطات الحقيقية لأبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية (البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد التمييزي) من جهة والمتوسطات الافتراضية من جهة أخرى، وكانت هذه الفروق لصالح المتوسطات الحقيقية لعينة الدراسة في أبعاد (البعد الاجتماعي، البعد التمييزي)، والتي كانت أعلى من المتوسطات الافتراضية؛ ما يبين ارتفاع مستوى كلٍّ من البعد الاجتماعي، البعد التمييزي لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام.

ولكن فيما يتعلق بالبعد النفسي فكانت هذه الفروق لصالح المتوسطات الافتراضية، والتي كانت أعلى من المتوسطات الحقيقية لدى عينة البحث من أمهات

أطفال متلازمة داون؛ ما يبين انخفاض مستوى البعد النفسي لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام. ولكن فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية فلم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحقيقي لهذا البعد من جهة والمتوسط الافتراضي من جهة أخرى، حيث بلغت مستوى الدلالة (٠.٢٨) وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥) وبالتالي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحقيقي لمقياس الوصمة الاجتماعية من جهة والمتوسط الافتراضي من جهة أخرى. وقد وُجد أن متوسط درجات الوصمة الاجتماعية يساوي (٦٦.٩٣) من (١١٠) وبوزن نسبي (٦٠.٨٥ %)، وحيث إنه حسب المحك المذكور سابقاً في جدول (٦) بأنه إذا بلغ مستوى الوصمة الاجتماعية من (٥٨ إلى ٧٥) فإن ذلك يعد مستوى متوسطاً من الوصمة الاجتماعية؛ لذلك فإن مستوى الوصمة الاجتماعية لدى عينة البحث من أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بالدمام يوجد بدرجة متوسطة.

وبالتالي لم تتحقق صحة الفرضية التي نصّها: "تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى مرتفع من الوصمة الاجتماعية"

وحيث إن مقياس الوصمة الاجتماعية يحتوي على ٣ أبعاد، وبالمقارنة بالمحك المذكور في جدول رقم (٦) فقد لوحظ أن البعد التمييزي جاء بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي يساوي (٢٤.١٠ من ٣٥) وبوزن نسبي (٦٨.٨٦ %)، وبمستوى متوسط، ويليه في المرتبة الثانية البعد الاجتماعي بمتوسط حسابي يساوي (٢٦.٠٢ من ٤٠) وبوزن نسبي (٦٥.٠٥ %) وبمستوى متوسط، ويليه في المرتبة الثالثة البعد النفسي بمتوسط حسابي يساوي (١٦.٨١ من ٣٥) وبوزن نسبي (٤٨.٠٣ %). وبمستوى منخفض.

توصّلت الدراسة الحالية إلى أنه تتسم أمهات أطفال متلازمة داون بمستوى متوسط من الوصمة الاجتماعية. اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة بدرانة (٢٠١٩) التي توصّلت إلى مستوى متوسط من الوصمة الاجتماعية مع تصورات أمهات ذوي اضطراب طيف التوحد. ودراسة الرياحنة (٢٠١٥) التي توصّلت إلى أن انتشار الوصمة الاجتماعية جاء متوسط لدى آباء وأمّهات أطفال متلازمة داون.

بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات الأخرى التي توصّلت إلى انخفاض (سالب) في الوصمة الاجتماعية مثل دراسة محمد (٢٠٢١). ودراسة متولي (٢٠٢١). ودراسة (werher & Shulman (2013) ودراسة (2010) hemmanti,solemani, soydnour dadkhah وكانت نتيجتها أن هناك أثراً سلبياً للوصمة الاجتماعية لدى أسر أطفال ذوي متلازمة داون.

ويمكن النظر إلى الوصمة الاجتماعية من خلال النظرية التفاعلية الرمزية على أن الفرد الموصوم يدرك معاني الوصمة من خلال التفاعل الرمزي مع الآخرين، وخاصة ردود فعل الآخر الذي يبني عليه مفهوم الذات، فالأفراد في المجتمع يكونون مفهومهم عن ذواتهم وتصوراتهم عن أنفسهم بناءً على ما يتوقعونه من ردود أفعال الآخرين في المجتمع نحوهم (محمد، ٢٠٢١).

جاء البعد التمييزي في المرتبة الأولى لأبعاد الوصمة الاجتماعية بمستوى متوسط لأمهات أطفال متلازمة داون، تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن سبب ما يعانيه المجتمع من عدم الوعي عن أمراض الطفولة عمومًا؛ ما ينعكس ذلك في تعامل المجتمع مع الأمهات والأطفال بشكل خاص، وعلى الأسرة التي يوجد بها طفل متلازمة داون .

أما البعد الاجتماعي من أبعاد الوصمة الاجتماعية فجاء بمستوى متوسط لأمهات أطفال متلازمة داون، وتفسر الباحثة ذلك إلى ما يعانيه الأمهات من الأشخاص المحيطين ومن المجتمع، رغم وعي الأمهات وتجاهلن لكثير من المواقف، إلا أنها تترك أثرًا سلبيًا في أنفسهن؛ وذلك يرجع إلى جهل المجتمع عن أسباب وطريقة التعامل مع أطفال متلازمة داون.

أما البعد النفسي فجاء منخفضًا، وهو أقل أبعاد الوصمة الاجتماعية لأمهات أطفال متلازمة داون، وترجع الباحثة ذلك إلى وعي الأمهات وتقبلهن لمرض أبنائهن وعدم لوم أنفسهن على مرض أبنائهن، ويرجع ذلك إلى مساعدة الأمهات من الوزارة متمثلة في وحدة الخدمات الاجتماعية بإعطائهن الخدمات التي يستحقها أبنائهن مثل الإعانة المالية.

وترى الباحثة أن هذه النتيجة من اهتمام الوزارة متمثلة في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالاهتمام بالأمهات، وتمكينهن نفسيًا من خلال تمكنهن من أدوات وطرق تخفيف الوصمة الاجتماعية لديهن، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى الحالة النفسية لديهن، وصولًا إلى تخفيف الوصمة لديهن إلى أقل درجة أو اختفائها.

وترى الباحثة أيضًا أنه بالرغم من التقدم العلمي الذي يشهده العالم، والإنجازات العلمية والتكنولوجية، إلا أننا مازلنا نعاني من قيم الجاهلية، وهي ثقافة الوصمة في وصف الإنسان بما ينقص من قدرة وشأنه، وكان لا بد لنا من وضع حد لهذه الألفة الخطيرة من خلال الدعم الاجتماعي الذي تخدمه الوزارة والمنظمات وموازرة هؤلاء الأمهات لكي يصبحن متوافقات نفسيًا، ويصبح لديهن القدرة على تحقيق ذاتهن واستقلال قدراتهن حتى يكن قادراتٍ على مواجهة مطالب الحياة وصعوباتها، وتمتعن بمستوى جيد من الصحة النفسية.

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: هل توجد علاقة داله احصائيا بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون بوحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة بمدينة الدمام؟
للإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون
لمعرفة العلاقة بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون، فقد تم استخدام اختبار Pearson بيرسون لاختبار العلاقة، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (٧) يُبين معاملات ارتباط Pearson بيرسون لاختبار العلاقة بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون

الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون			المقياس
القرار الإحصائي	مستوى الدلالة	معامل الارتباط	الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون
توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية	٠.٠١	-.٤٥٨**	

** دال عند مستوى الدلالة ٠,٠١ فأقل.

يتضح من الجدول رقم (٧) أنه توجد علاقة ارتباط عكسية (سالبة) ذات دلالة إحصائية بين الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون والدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون، حيث بلغ معامل الارتباط (-٠.٤٥٨)، وهذا يدل على أنه كلما زادت الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون أدى ذلك إلى انخفاض درجات الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون، وهذا يشير إلى أن كلما كانت أمهات أطفال متلازمة داون لديهن شفقة بذاتهن، قلت الوصمة الاجتماعية لديهن، والعكس صحيح كلما انخفضت الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون، زادت الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون.

جاءت هذه النتيجة متفقة مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقة عكسية بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية، مثل دراسة إبراهيم (٢٠٢٣) أن برنامج الألعاب الترويحية ذو تأثير إيجابي في تحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم. كما أكدت دراسة عبدالإله وسليمان وعبدالله (٢٠٢٣) على أنه توجد علاقة ارتباطية سالبة بين الوصمة المدركة والشفقة بالذات لدى آباء وأمّهات التلاميذ ذوي الإعاقة العقلية. ودراسة أبو بكر

(٢٠٢٢) جاءت نتائجها تؤكد وجود علاقة ارتباطية سالبة بين الوصمة الاجتماعية والشفقة بالذات لدى آباء وأمهات أطفال طيف التوحد.

واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (Wong, Mak, & Liao, 2016) التي أشارت إلى وجود علاقة ارتباطية بين الشعور بالوصمة الاجتماعية وكلٍّ من القلق والاكتئاب، ووجود علاقة ارتباطية بين الشعور بالوصمة وكلٍّ من الشفقة بالذات تتوسط العلاقة بين الشعور بالوصمة والقلق والاكتئاب.

وقد ذكرت صدقة ووديع (٢٠١٩) أن الأفراد المشفقين بذاتهم يسهل عليهم تشكيل الروابط الاجتماعية، ويترددون في تجاهلها؛ لأنها تشكل عواطف إيجابية لذواتهم، ويؤكد أن الآثار المترتبة على الشعور بالوصمة هي تدني احترام الذات، وعدم الثقة بالذات واللامبالاة (أحمد، ٢٠١٦).

وترى الباحثة أن هذه نتيجة منطقية؛ لأنه كلما زاد حب الذات والعطف على الأم وعدم لومها أدى ذلك إلى تقبُّل مرض أطفالهن، وصد الصدمات عليهن وعلى أبنائهن. وهذا يدلُّ على أنه كلما زادت الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون أدى ذلك إلى انخفاض درجات الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وهذا يشير إلى أنه كلما كانت أمهات أطفال متلازمة داون لديهن شفقة بذاتهن قلَّت الوصمة الاجتماعية لديهن والعكس صحيح، كلما انخفضت الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون زادت الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون.

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع: هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي، العمر)؟
للإجابة عن هذا السؤال تمَّ صياغة الفرضية التالية:

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر)"

للإجابة عن هذا السؤال والتحقُّق من صحة الفرضية السابقة فقد تمَّ استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One -Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر)، والجدول التالية توضح ذلك:

أولاً: الفروق حسب المستوى التعليمي:

جدول (٨) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One –Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً لمتغير المستوى التعليمي

أبعاد مقياس الشفقة بالذات	مصدر التباين	مجموع مربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف (F)	الدلالة الإحصائية
الرحمة بالذات	بين المجموعات	٦.١٤	٢	٣.٠٧	٠.٣٤	٠.٧١
	داخل المجموعات	١٣٣٣.٣٤	١٤٧	٩.٠٧		
	المجموع	١٣٣٩.٤٧	١٤٩			
الحكم الذاتي	بين المجموعات	٣٧.٢٢	٢	١٨.٦١	٢.١٣	٠.١٢
	داخل المجموعات	١٢٨٥.٨٥	١٤٧	٨.٧٥		
	المجموع	١٣٢٣.٠٧	١٤٩			
الإنسانية العامة	بين المجموعات	٩.٣١	٢	٤.٦٥	٠.٦٨	٠.٥١
	داخل المجموعات	١٠٠٧.٢٩	١٤٧	٦.٨٥		
	المجموع	١٠١٦.٥٩	١٤٩			
العزلة	بين المجموعات	٤١.٧٠	٢	٢٠.٨٥	٢.٣٠	٠.١٠
	داخل المجموعات	١٣٣١.٤٧	١٤٧	٩.٠٦		
	المجموع	١٣٧٣.١٧	١٤٩			
اليقظة العقلية	بين المجموعات	١٣.٩٣	٢	٦.٩٦	١.٤٢	٠.٢٤
	داخل المجموعات	٧١٩.٥٧	١٤٧	٤.٩٠		
	المجموع	٧٣٣.٥٠	١٤٩			
الإفراط في التوحد	بين المجموعات	٣٤.٥٢	٢	١٧.٢٦	١.٩١	٠.١٥
	داخل المجموعات	١٣٢٥.٧٥	١٤٧	٩.٠٢		
	المجموع	١٣٦٠.٢٧	١٤٩			
الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات	بين المجموعات	٣٥٨.٩٠	٢	١٧٩.٤٥	١.٦٧	٠.١٩
	داخل المجموعات	١٥٧٧٣.٩٣	١٤٧	١٠٧.٣١		
	المجموع	١٦١٣٢.٨٣	١٤٩			

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبين في الجدول السابق أن قيمة (ف) بلغت (١.٦٧)، وأن مستوى الدلالة لمقياس الشفقة بالذات بلغ (٠.١٩) وهي أكبر من (٠.٠٥) وبذلك فهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha \geq 0.05$) وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائياً في الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للمستوى التعليمي.

وفيما يتعلق بأبعاد الشفقة بالذات فقد تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أبعاد الشفقة بالذات (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة، اليقظة العقلية، الإفراط في التوحد) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للمستوى التعليمي، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠.٧١، ٠.١٢، ٠.٥١، ٠.١٠، ٠.٢٤، ٠.١٥) على التوالي وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد

عينة الدراسة في (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة، اليقظة العقلية، الإفراط في التوحد)) وفقاً المستوى التعليمي.

أسفرت نتيجة هذه الفرضية أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي لدى أمهات أطفال متلازمة داون، اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كلٍّ من محمد (٢٠١٨) التي توصّلت إلى عدم وجود فروق في مقياس الشفقة بالذات لدى آباء وأمهات ذوي الإعاقة العقلية بالنسبة للمستوى التعليمي.

واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة رضوان (٢٠١٩) التي توصّلت نتیجتها إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الشفقة بالذات لمتغير المستوى التعليمي لدى أمهات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لصالح المستوى التعليمي الأعلى.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن الأمهات مهما اختلف مستواه التعليمي فهي أم والام لا تحتاج الى تعليم لتمارس دورا الامومة فهناك ارتباط عضوي ونفسي بين الام والطفل وتلك العواطف التي جبل الله عليها قلوب الأمهات هي معجزه الهية كبرى من شأنها استمرار عجلة الحياة ولولا هذه المشاعر والاحاسيس لما تربي طفل ولما كبر رضيع او شب صغير فلا يمكن لعاطفة في الدنيا ان تطقوا على مشاعر الام وعواطفها. فهناك برمجته غريزية او دعها الخالق جل وعلا للاستجابة والتفاعل بين الام وولديها.

ثانياً: الفروق حسب العمر

جدول (٩) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One –Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً لمتغير العمر

أبعاد مقياس الشفقة بالذات	مصدر التباين	مجموع مربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف (F)	الدلالة الإحصائية
الرحمة بالذات	بين المجموعات	٥٦.٠٢	٤	١٤.٠١	١.٥٨	٠.١٨
	داخل المجموعات	١٢٨٣.٤٥	١٤٥	٨.٨٥		
	المجموع	١٣٣٩.٤٧	١٤٩			
الحكم الذاتي	بين المجموعات	٤٢.٤١	٤	١٠.٦٠	١.٢٠	٠.٣١
	داخل المجموعات	١٢٨٠.٦٧	١٤٥	٨.٨٣		
	المجموع	١٣٢٣.٠٧	١٤٩			
الإنسانية العامة	بين المجموعات	٣٣.٤٠	٤	٨.٣٥	١.٢٣	٠.٣٠
	داخل المجموعات	٩٨٣.١٩	١٤٥	٦.٧٨		
	المجموع	١٠١٦.٥٩	١٤٩			
العزلة	بين المجموعات	١١.٠٠	٤	٢.٧٥	٠.٢٩	٠.٨٨
	داخل المجموعات	١٣٦٢.١٧	١٤٥	٩.٣٩		
	المجموع	١٣٧٣.١٧	١٤٩			
اليقظة العقلية	بين المجموعات	٦٤.٩١	٤	١٦.٢٣	٣.٥٢	٠.٠١

		٤,٦١	١٤٥	٦٦٨,٥٩	داخل المجموعات	
			١٤٩	٧٣٣,٥٠	المجموع	
٠,٠١	٣,٣٥	٢٨,٧٥	٤	١١٤,٩٩	بين المجموعات	الإفراط في التوحد
		٨,٥٩	١٤٥	١٢٤٥,٢٨	داخل المجموعات	
			١٤٩	١٣٦٠,٢٧	المجموع	
٠,٠٧	٢,٢٠	٢٣١,٠٦	٤	٩٢٤,٢٥	بين المجموعات	الدرجة الكلية لمقياس الشفقة بالذات
		١٠٤,٨٩	١٤٥	١٥٢٠,٥٨	داخل المجموعات	
			١٤٩	١٦١٣٢,٨٣	المجموع	

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبين في الجدول السابق أن قيمة (ف) بلغت (٢,٢٠)، وأن مستوى الدلالة لمقياس الشفقة بالذات بلغ (٠,٠٧) وهي أكبر من (٠,٠٥) وبذلك فهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha \geq 0.05$) وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائية في الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية.

وفيما يتعلق بأبعاد الشفقة بالذات فقد تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائية في متوسطات درجات أبعاد الشفقة بالذات (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠,١٨، ٠,٣١، ٠,٣٠، ٠,٨٨) على التوالي وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في (الرحمة بالذات، الحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة) وفقاً للفئة العمرية.

ولكن فيما يتعلق بأبعاد الشفقة بالذات فقد تبين أنه توجد فروق دالة إحصائية في متوسطات درجات أبعاد الشفقة بالذات (اليقظة العقلية، الإفراط في التوحد) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠,٠١، ٠,٠١) على التوالي وهي أقل من مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠,٠٥).

تشير النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية للشفقة بالذات لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغير العمر، حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة رضوان (٢٠١٩) والتي جاءت نتائجها توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تبعاً لمتغير عمر الأم لصالح العمر الأكبر (٣٦-٤٢) سنة.

بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة Arnos (2017) التي توصلت إلى عدم وجود فروق في إدراك الضغوط النفسية والشفقة بالذات بالنسبة لأباء وأمّهات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التواصل بالنسبة لعمر الطفل.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة لما لعمر الأم من تأثير كبير على الفهم والإدراك، وأن نظرة الأم للأمور تختلف من فئة عمرية إلى أخرى، وأيضاً العمر يؤثر على طريقة تقبل المرض والمعلومات عنه؛ ما يؤدي إلى زيادة أو انخفاض الشفقة بالذات من فئة عمرية إلى أخرى. أما أبعاد الشفقة بالذات المتمثلة في (بُعد الرحمة بالذات، والحكم الذاتي، الإنسانية العامة، العزلة) لدى أمهات أطفال متلازمة داون فلا تتأثر بالفئة العمرية.

وجاء بعد اليقظة العقلية البعد الوحيد من أبعاد الشفقة بالذات الذي يتأثر بالعمر، واليقظة العقلية هي طريقة التفكير التي تركز على انتباه الفرد إلى بيئته وأحاسيسه الداخلية دون إصدار حكم، ونجد أن الوالدين ذوي اليقظة العقلية المرتفعة أكثر انسجاماً مع أنفسهم وأطفالهم. وجاء لصالح الفئة العمرية أقل من ٣٠ سنة، من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة؛ لأنه في هذا العمر تكون الأم في أعلى درجات الوعي والنضج العقلي، ويعني هذا تحمل الطفل غير المشروط والوعي باحتياجاته والتعاطف معه وتحمل المسؤولية تجاه الطفل وحل مشكلاته.

ولمعرفة اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات متغير الفئة العمرية، تم استخدام اختبار شيفيه (Scheffe)، وظهرت النتائج على النحو الموضح في الجدول رقم (١٠)

جدول (١٠) اختبار شيفيه (Scheffe) للفروق بين متوسطات أبعاد الشفقة بالذات (اليقظة العقلية، الإفراط في التوحد) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً لمتغير الفئة العمرية

الأبعاد	الفئة العمرية	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	أقل من ٣٠ سنة	من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة	من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة	من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة	٦٠ سنة فأكثر
اليقظة العقلية	أقل من ٣٠ سنة	١٠	١٥.٨٠	١.١٤		١.٥١*			١.٨٠*
	من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة	٤١	١٤.٢٩	٢.٣٧					
	من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة	٥٦	١٥.٥٠	٢.٢٢		١.٢١*			١.٥٠*
	من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة	٢٥	١٤.٠٠	٢.٠٢					
	٦٠ سنة فأكثر	١٨	١٥.١٧	١.٩٢					
الإفراط في التوحد	أقل من ٣٠ سنة	١٠	١١.١٠	١.٨٥					
	من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة	٤١	١١.٧٨	٢.٨٧					
	من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة	٥٦	١٢.٣٦	٢.٩٨					
	من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة	٢٥	١٢.٠٠	٣.٥٧					
	٦٠ سنة فأكثر	١٨	١٤.٥٠	٢.٣٣	٣.٤٠*	٢.٧٢	٢.١٤*	٢.٥٠*	

يتضح من الجدول السابق:

١- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في بُعد اليقظة العقلية باختلاف الفئة العمرية، وقد تبين من خلال المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (أقل من ٣٠ سنة، من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة)؛ ما يدل على أن أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (أقل من ٣٠ سنة، من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة) لديهن اليقظة العقلية أعلى من أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة، من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة).

٢- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في بُعد الإفراط في التوحد باختلاف الفئة العمرية، وقد تبين من خلال المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (٦٠ سنة فأكثر)؛ ما يدل على أن أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (٦٠ سنة فأكثر) لديهن الإفراط في التوحد أعلى من أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي أعمارهن (أقل من ٣٠ سنة، من ٣٠ إلى أقل من ٤٠ سنة، من ٤٠ إلى أقل من ٥٠ سنة، من ٥٠ إلى أقل من ٦٠ سنة).

تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الخامس: هل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي، العمر)؟
للإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الوصمة الاجتماعية تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي، العمر) لدى أمهات أطفال متلازمة داون"

للإجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One -Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون تُعزى لمتغيري (المستوى التعليمي - العمر)، والجدول التالي توضح ذلك:
أولاً: الفروق حسب المستوى التعليمي

جدول (١١) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One -Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً لمتغير المستوى التعليمي

أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية	مصدر التباين	مجموع مربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف (F)	الدلالة الإحصائية
البعد النفسي	بين المجموعات	١٤٨.٩٣	٢	٧٤.٤٦	٥.٧٥	٠.٠١
	داخل المجموعات	١٩٠٤.٤٦	١٤٧	١٢.٩٦		
	المجموع	٢٠٥٣.٣٩	١٤٩			
البعد الاجتماعي	بين المجموعات	٢٦٣.١٢	٢	١٣١.٥٦	٥.١٤	٠.٠١
	داخل المجموعات	٣٧٥٩.٨٢	١٤٧	٢٥.٥٨		

			١٤٩	٤٠٢٢.٩٤	المجموع	
٠.٠٩	٢.٤٩	٣٧.٠٨	٢	٧٤.١٦	بين المجموعات	البعد التمييزي
		١٤.٩٢	١٤٧	٢١٩٣.٣٤	داخل المجموعات	
			١٤٩	٢٢٦٧.٥٠	المجموع	
٠.٠١	٥.٩٧	٦٠٥.١٦	٢	١٢١٠.٣٢	بين المجموعات	الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية
		١٠١.٢٩	١٤٧	١٤٨٨٩.٨٧	داخل المجموعات	
			١٤٩	١٦١٠٠.١٩	المجموع	

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبين في الجدول السابق رقم (١١) أن قيمة (ف) بلغت (٥.٩٧)، وأن مستوى الدلالة لمقياس الوصمة الاجتماعية بلغ (٠.٠١) وهي أقل من (٠.٠٥) وبذلك فهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha \geq 0.05$) وبالتالي توجد فروق دالة إحصائياً في الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للمستوى التعليمي.

وفيما يتعلق بأبعاد الوصمة الاجتماعية فقد تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات (البعد التمييزي) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للمستوى التعليمي، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠.٠٩) وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون في البعد التمييزي باختلاف المستوى التعليمي للأم.

ولكن فيما يتعلق بأبعاد الوصمة الاجتماعية فقد تبين أنه توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أبعاد الوصمة الاجتماعية (البعد النفسي، البعد الاجتماعي) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للمستوى التعليمي للأم، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠.٠١، ٠.٠١) على التوالي وهي أقل من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠.٠٥)،

جاءت نتيجة الفرضية أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الوصمة الاجتماعية تُعزى لمتغير المستوى التعليمي لدى أمهات أطفال متلازمة داون. واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة محمد (٢٠١٢) التي توصلت إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقات النمائية للوصمة الاجتماعية وفق متغير الوصمة الاجتماعية وفق متغير المستوى التعليمي. ودراسة السيد (٢٠١٨) وتوصلت نتيجتها إلى تأثير المستوى التعليمي على شعور أمهات أطفال متلازمة داون بالوصمة الاجتماعية. ولم تجد الباحثة نتيجة دراسة سابقة اختلفت مع نتيجة الدراسة الحالية على حسب علم الباحثة. وتفسر الباحثة النتيجة أن التعليم يُغيّر من طريقة تفكير الأم ومقدرتها على مواجهة المجتمع بعاداته وتقاليده والنظرة السلبية.

ولمعرفة اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات متغير المستوى التعليمي للأم، تمَّ استخدام اختبار شيفيه (Scheffe)، وظهرت النتائج على النحو الموضح في الجدول رقم (١٢)

جدول (١٢) اختبار شيفيه (Scheffe) للفروق بين متوسطات الدرجة الكلية للوصمة الاجتماعية وأبعادها (البعد النفسي، البعد الاجتماعي) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً لمتغير المستوى التعليمي للأم

الأبعاد	المستوى التعليمي للأم	ن	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	أمي	ثانوية عامة فما دون	بكالوريوس فأعلى
البعد النفسي	أمي	١٧	١٩.٥٣	٣.٠٤		*٢.٨٦	*٣.٣٢
	ثانوية عامة فما دون	٧٢	١٦.٦٧	٣.٦٢			
	بكالوريوس فأعلى	٦١	١٦.٢١	٣.٧١			
البعد الاجتماعي	أمي	١٧	٢٨.٠٠	٣.٩٧			*٣.٥٢
	ثانوية عامة فما دون	٧٢	٢٦.٨٦	٥.١٧			
	بكالوريوس فأعلى	٦١	٢٤.٤٨	٥.١٨			
الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية	أمي	١٧	٧٢.٩٤	٩.٢٧		*٤.٩٧	٨.٩٢
	ثانوية عامة فما دون	٧٢	٦٧.٩٧	٩.٨٢			
	بكالوريوس فأعلى	٦١	٦٤.٠٢	١٠.٥٤			

يتضح من الجدول السابق رقم (١٢) أنه:

١- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في البُعد النفسي باختلاف المستوى التعليمي للأم، وقد تبين من خلال المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي)؛ ما يدلُّ على أن أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي) لديهن البعد النفسي أعلى من أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (ثانوية عامة فما دون، بكالوريوس فأعلى).

٢- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في البُعد الاجتماعي باختلاف المستوى التعليمي للأم، وقد تبين من خلال المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي)؛ ما يدلُّ على أن أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي) لديهن البعد الاجتماعي أعلى من أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (بكالوريوس فأعلى).

٣- يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية باختلاف المستوى التعليمي للأم، وقد تبين من خلال المتوسطات الحسابية أن هذه الفروق لصالح أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي)؛ ما يدلُّ على أن أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (أمي) لديهن الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية أعلى من أفراد الدراسة من أمهات أطفال متلازمة داون اللاتي مستواه التعليمي (ثانوية عامة فما دون، بكالوريوس فأعلى).

فما دون، بكالوريوس فأعلى). جاءت النتيجة للبعد النفسي والبعد الاجتماعي والدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية جاءت لصالح لمستوى التعليمي أُمي. وتفسر الباحثة ذلك من حيث أهمية التعليم بوعي الذات وفهم المجتمع، فالأمية تدمر الأم والطفل والمجتمع، فالأم التي تعي وتعرف واجباتها اتجاه نفسها وطفلها والمجتمع هي القادرة على مواجهة المجتمع. وشهدت العقود الماضية اهتمامًا متزايدًا من قبل المختصين والباحثين والتربويين بدراسة موضوع العلاقة بين الأبناء والأم والمدرسة. وفي أمريكا وأوروبا يتم التركيز على زيادة الوعي لدى الأمهات وثقافتهن وأهمية الممارسة التعليمية التي تراعي قدرات ودرجة الإعاقات الجسمية والعقلية. فالجو الثقافي سائد داخل الوسط الأسري، ويتمثل في اتجاهات الوالدين ومستواهم التعليمي. كلما كان المستوى التعليمي عاليًا كانت الأسرة أكثر استقرارًا، وزادت مساحة التفاهم المشترك بين الوالدين، ونجد أن أكبر إجمالي أفراد الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي لدى أمهات أطفال متلازمة داون مستواهم التعليمي (ثانوي فما دون) ويلبها (بكالوريوس فأعلى) وهذا يصب في صالح الطفل، فكلما كانت الأم ذات مستوى تعليمي مرتفع كان هناك طفل متوازن ومواجه للحياة، وكلما كانت الأم مستواها التعليمي أقل (أُمي) كان هناك أبناء ذوي خلل في الشخصية والثقة، فالأم ذات التعليم (الأُمي) يكون أمامها تحدي المواجهة؛ مما يمارسه المجتمع عليها نفسيًا بطرق مدركة وغير مدركة، ويبدأ عليها الحرج والانطواء وهي من الآثار المترتبة على الشعور بالوصمة الاجتماعية.

ثانيًا: الفروق حسب العمر

جدول (١٣) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One –Way-ANOVA) لمعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقًا لمتغير العمر

أبعاد مقياس الوصمة الاجتماعية	مصدر التباين	مجموع مربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف (F)	الدلالة الإحصائية
البعد النفسي	بين المجموعات	٧٣.٦١	٤	١٨.٤٠	١.٣٥	٠.٢٦
	داخل المجموعات	١٩٧٩.٧٨	١٤٥	١٣.٦٥		
	المجموع	٢٠٥٣.٣٩	١٤٩			
البعد الاجتماعي	بين المجموعات	١٢٥.٩٢	٤	٣١.٤٨	١.١٧	٠.٣٣
	داخل المجموعات	٣٨٩٧.٠٢	١٤٥	٢٦.٨٨		
	المجموع	٤٠٢٣.٩٤	١٤٩			
البعد التمييزي	بين المجموعات	٦٧.٣٦	٤	١٦.٨٤	١.١١	٠.٣٥
	داخل المجموعات	٢٢٠٠.١٤	١٤٥	١٥.١٧		
	المجموع	٢٢٦٧.٥٠	١٤٩			
الدرجة الكلية لمقياس الوصمة الاجتماعية	بين المجموعات	٤٢٠.١٢	٤	١٠٥.٠٣	٠.٩٧	٠.٤٣
	داخل المجموعات	١٥٦٨٠.٠٨	١٤٥	١٠٨.١٤		
	المجموع	١٦١٠٠.١٩	١٤٩			

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبين في الجدول السابق رقم (١٣) أن قيمة (ف) بلغت (٠.٩٧)، وأن مستوى الدلالة لمقياس الوصمة الاجتماعية بلغ (٠.٤٣) وهي أكبر من (٠.٠٥) وبذلك فهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha \geq 0.05$) وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائياً في الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية.

وفيما يتعلق بأبعاد الوصمة الاجتماعية فقد تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أبعاد الوصمة الاجتماعية (البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد التمييزي) لدى أمهات أطفال متلازمة داون وفقاً للفئة العمرية، حيث بلغت مستويات الدلالة (٠.٢٦، ٠.٣٣، ٠.٣٥) على التوالي وهي أكبر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (٠.٠٥)، وبالتالي لا توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة في (البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد التمييزي) وفقاً للفئة العمرية.

جاءت النتيجة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الوصمة الاجتماعية تُعزى لمتغير العمر لدى أمهات أطفال متلازمة داون، اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة محمد (٢٠٢٢) التي توصلت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الوصمة الاجتماعية في متغير العمر لأمهات الأطفال المعاقين ذهنياً، وأيضاً دراسة السيد (٢٠١٨) التي جاءت نتيجتها لا تتأثر الوصمة بالعمر بالنسبة لأمهات أطفال متلازمة داون.

بينما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى مثل دراسة الرباحنة (٢٠١٥) التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية للوصمة الاجتماعية لدى أسر أطفال متلازمة داون لمتغير عمر الأم وعمر الطفل. وتفسر الباحثة النتيجة أن العمر لا يؤثر على تحقيق الوصمة الاجتماعية، حيث إن جميع الأمهات يتأثرن بعادات المجتمع ونظراته الدونية للطفل المصاب ولأسرته مهما كان عمر الأم، ويؤكد هذا أن جميع أبعاد الوصمة الاجتماعية في متوسطات درجاتها لا توجد فروق، فالبعد النفسي لا يتأثر بالعمر؛ لأنه مهما اختلف العمر فالنفس البشرية واحدة، وتتأثر وتتألم بالكلمات الجارحة والنظرات الدونية التي يتعرض لها الطفل وأسرته من قبل الآخرين، وأما البعد الاجتماعي فهو يعتمد على المجتمع وعاداته السيئة التي لا تفرق بين كبير أو صغير في العمر، فهي قاسية في حكمها على الجميع، أما البعد التمييزي فجاء في المرتبة الأولى في الأبعاد والبعد التمييزي بمستوى متوسط لأمهات أطفال متلازمة داون. وتعزو الباحثة السبب إلى أنه قد يجرح البعض مشاعر الآخرين بأسئلة أو تعليقات عابرة أو سلوكيات متكررة على مدار اليوم، وهذا يدل على التحامل والتمييز غير المباشر. وهذا التمييز يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس والشعور بالإقصاء والتهميش قد يسبب في النهاية مشاكل نفسية،

وهذه التصرفات تجعل الأشخاص يتعرّضون للتمييز، ويشعرون بأنهم مختلفون أو غرباء أو مثيرون للريبة والخوف، ويجب علينا مساندة أمهات أطفال متلازمة داون والاطمئنان عليهم وليشعروا أنهم جزء من المجتمع، وهذا يساهم في حمايتهم من الأذى النفسي.

توصيات البحث:

١. عمل برامج تلفزيونية وإذاعية وربطها بمواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة تغيير صورة المجتمع عن أطفال متلازمة داون.
٢. ضرورة عمل دورات تدريبية وورش لتحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال متلازمة داون.
٣. إعداد المزيد من البرامج الإرشادية لأسر أطفال متلازمة داون في المناطق النائية والبعيدة عن أماكن الخدمات وخاصة التركيز على أمهات ذات المستوى التعليمي المتدني.
٤. ضرورة زيادة جهود الجمعيات الخيرية والوزارات المعنية بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتأهيل والحماية لأطفال متلازمة داون وأسره.
٥. عمل مراكز لتطوير القدرات اللغوية والنطقية للأطفال ذوي متلازمة داون من خلال برنامج الكلام والنطق وعمل برنامج الدمج المدرسي والمجتمعي.

البحوث المقترحة:

١. فاعلية برنامج إرشادي معرفي لتحسين الشفقة بالذات لدى أمهات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
٢. مستوى الوصمة الاجتماعية لدى أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة.
٣. نمذجة العلاقات بين الشفقة بالذات والوصمة الاجتماعية والصمود الاسري لدى أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة.
٤. الشفقة بالذات كمتغير وسيط بين الوصمة الاجتماعية والتوافق الاسري.
٥. الشفقة بالذات والمساندة الاجتماعية لمنبات الوصمة الاجتماعية لدى أمهات ذوي الاعاقة.

المراجع

المراجع العربية:

- إبراهيم، أحمد محمد شوقي. (٢٠٢٣). برنامج ألعاب ترويحوية لتحسين الشفقة بالذات وخفض الوصمة الاجتماعية لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم. مجلة أسبوط لعلوم وفنون التربية الرياضية، جامعة أسبوط، 64 (4).
- أبو المعاطي، ماهر. (٢٠٠٤). الخدمة الاجتماعية في مجال الفئات الخاصة. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- أبو حشيش، حسن. (٢٠٢٢). برنامج إرشادي انتقائي في تحسين الشفقة بالذات وخفض الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال اضطراب التوحد. مجلة التربية، ع ١٩٤، ج ١، ٣٥٧-٤٠٢.
- أبو زيد، مدحت عبدالحميد (٢٠١٥) علم نفس الطفل "الخوف والرهاب لدى الأطفال" -الإسكندرية -دار المعرفة الجامعية.
- أوبكر، أحمد. (٢٠٢٢). الشفقة بالذات كمتغير وسيط بين الوصمة الاجتماعية والوالدية البقطة عقلياً لدى آباء وأمهات أطفال اضطراب طيف التوحد. مجلة البحث في التربية وعلم النفس، ٣٧(٢).
- بدران، أحمد. (٢٠١٩). تصورات أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد للوصمة في ضوء بعض المتغيرات [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة اليرموك، كلية التربية، قسم علم النفس الإرشادي والتربوي.
- بدر، رقية السيد الطيب عباس. (٢٠١١). سمات الشخصية المميزة للأفراد المصابين بمتلازمة داون. مجلة جامعة السودان المفتوحة، جامعة السودان المفتوحة.
- البلوي، خليل. (٢٠١١). دور الوصم الاجتماعي في العود إلى الجريمة "دراسة ميدانية على العائدين إلى الجريمة في سجن تبوك المركزي في المملكة العربية السعودية" [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة اليرموك. الأردن.
- النريني، محمد محمود أمين. (٢٠٢٢). الشفقة بالذات وعلاقتها بالضغوط الحياتية لدى المراهقين بدور الأيتام. مجلة كلية التربية، جامعة القاهرة، 5 (194).
- جعفر، غسان. (٢٠٠١). التخلف العقلي عند الأطفال. بيروت: دار الحرف العربي.
- جوهر، إيناس. (٢٠٢١). الشفقة بالذات كمدخل لخفض الاكتئاب لدى عينة من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. مجلة الطفولة والتربية، ٣ (٤٨).
- الحسن، إحسان محمد. (٢٠٠٥). النظريات الاجتماعية المتقدمة "دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة" (ط١). الأردن: دار وائل للنشر.
- حنون، مصطفى فارس مصطفى. (٢٠٢٢). فعالية برنامج إرشادي إنساني في تنمية التمكين المعرفي والشفقة بالذات لدى أسر ذوي الإعاقة الفكرية المشخصين حديثاً [رسالة دكتوراه غير منشورة]. جامعة مؤتة. الأردن.

- حنون، مصطفى فارس مصطفى، القرالة، عبدالناصر موسى إسماعيل. (٢٠٢٢). الشفقة بالذات وعلاقتها بالتمكين المعرفي لدى أسر ذوي الإعاقة الفكرية المشخصين حديثاً. مجلة التربية، جامعة الأزهر، ٣ (١٩٤).
- الدوسري، ياسر بن راشد. (٢٠٢١). مقصد الشفقة "دراسة تطبيقية على المسائل الفقهية". مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، (86).
- رضوان، بدوية. (٢٠١٩). الشفقة بالذات وعلاقتها بالصمود النفسي وقلق المستقبل لدى أمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. مجلة كلية التربية، ٢٩ (٦).
- الروسان، فاروق. (٢٠٠٥). مقدمة في الإعاقة العقلية. عمان: دار الفكر للنشر.
- الرياحنة، أيوب عاطف إبراهيم. (٢٠١٥). الوصمة الاجتماعية والتوافق الأسري لدى أسر الأطفال متلازمة داون [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة تبوك. الأردن.
- الزبيد، نادر فهمي. (٢٠٠٥). تعليم الأطفال المتخلفين عقلياً. عمان: دار الفكر.
- سعد، أماني عادل. (٢٠٢٠). النموذج البنائي للعلاقة بين الشفقة بالذات والنهوض الأكاديمي لدى طلاب الصف الأول الثانوي. مجلة كلية التربية، ٣١ (١٢١).
- السمحة، حمود. (٢٠٢٠). الشفقة بالذات كمنبئ للشعور بالتماسك لدى آباء وأمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. المجلة السعودية للعلوم النفسية، ٤٤، ٩٥-١١٥.
- سيد، سعاد كامل قرني. (٢٠٢١). فعالية الإرشاد المعرفي القائم على اليقظة العقلية في تحسين الشفقة بالذات وأثره على وصمة الذات لطلاب الجامعة المعاقين حركياً. المجلة التربوية كلية التربية، جامعة سوهاج، 91 (1).
- السيد، عاشور. (٢٠١٧). المشكلات الاجتماعية والنفسية لأمهات أطفال متلازمة داون: دراسة من منظور طريقة العمل مع الجماعات. مجلة الخدمة الاجتماعية، ٤ (٥٧).
- السيد، هبة. (٢٠١٨). محددات الوصمة العائلية كما تدركها أمهات الأطفال ذوي متلازمة داون. مجلة البحث العلمي في التربية، ٦ (١٩).
- الشاذلي، وائل أحمد سليمان. (٢٠١٨). فاعلية التدريب على اليقظة العقلية في تحقيق الوصمة الاجتماعية المدركة لدى عينة من المطلقات من طالبات الدراسات العليا. مجلة الثقافة والتنمية، جمعية الثقافة من أجل التنمية، ١٣ (١٩).
- الشربيني، السيد كامل. (٢٠١٦). المرونة النفسية والعصابية والشفقة بالذات والأساليب الوجدانية لدى طلاب قسم التربية الخاصة والعلاقات والتدخل. مجلة التربية الخاصة، جامعة الزقازيق، (16).
- العاسمي، رياض نايل. (٢٠١٤). الشفقة بالذات وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طلاب جامعة الملك خالد. مجلة جامعة دمشق، 30 (1).

- عباس، سوسن حبيب. (٢٠٠٩). نماذج لألعاب تربوية مصممة لخدمة أطفال متلازمة داون. مجلة الطفولة العربية. 11 (41).
- عباس، منال محمد. (٢٠١١). الانحراف والجريمة في عالم متغير. دار المعرفة الجامعية.
- عبدالخالق، إيمان يحيى محمد. (٢٠٢٠). الشفقة بالذات وعلاقتها بالصمود النفسي لدى عينة من ذوي اضطرابات الأكل. مجلة دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.
- عبدالله، يوسف، سليمان، وائل، عبدالله، سماح. (٢٠٢٣). الوصمة المدركة وعلاقتها بالشفقة بالذات لدى آباء وأمهات التلاميذ ذوي الإعاقة العقلية، مجلة كلية التربية، جامعة سوهاج، ٣ (٤).
- عبدالله، عادل. (٢٠٠٤). الأطفال التوحيديون "دراسات تشخيصية وبرامجية". القاهرة: دار الرشاد.
- عبدالله، محمد، أبو المجد، عبير. (٢٠٢٠). فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في تحسين التوجه نحو الحياة وأثره في خفض الشعور بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات الأطفال ذوي متلازمة داون. مجلة التربية الخاصة، جامعة الزقازيق، (٣١).
- العبري، وليد حسن باتل. (٢٠٠٣). دراسة لبعض مظاهر النمو عند أطفال متلازمة داون مقارنة بنظراتهم من المتخلفين عقلياً [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الخليج العربي. البحرين.
- عسلي، كوثر حسن. (٢٠٠٦). طفل متلازمة داون. الأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- علام، سحر فاروق. (٢٠١٧). النموذج البنائي للعلاقات السببية بين التمعن والتنظيم الانفعالي والتراحم بالذات لدى طلاب الجامعة. دراسات نفسية. رابطة الاخصائيين النفسيين المصريين (رأى) ٢٠٠ (١).
- العميري، سهيلة عيسى. (٢٠٠١). فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى أطفال متلازمة داون من ذوي التخلف العقلي البسيط في مرحلة ما قبل المدرسة [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة الخليج العربي. البحرين.
- عيسى، دعاء فتحي معوض. (٢٠٢٣). الشفقة بالذات وعلاقتها بالاتجاهات الوالدية والرضا عن الحياة لدى أمهات الأطفال ذوي الإعاقة العقلية. مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، ٣٨ (١).
- الغرايبة، محمود محمد عوض. (٢٠٢١). القدرة التنبؤية لليقظة العقلية والشفقة بالذات والاهمية للآخرين بالجهد الانفعالي لدى العاملين في مجال الصحة النفسية [رسالة دكتوراه غير منشورة]. جامعة اليرموك. الأردن.
- لطي الشربيني (١٩٩٧): مجلة شبكة العلوم النفسية والعربية، العدد الحادي والثلاثون، م ٨، مركز الدراسات النفسية الحديثة.

متولي، فكري لطيف. (٢٠٢٠). فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في تحسين التوجه نحو الحياة وأثره في خفض الشعور بالوصمة الاجتماعية لدى أمهات أطفال ذوي متلازمة داون. مجلة التربية الخاصة، جامعة الزقازيق، ٩ (٣١).

محمد، داليا محمد همام. (٢٠٢٢). الوصمة الاجتماعية وأساليب مواجهة الضغوط منبئات بالألكسثيميا لدى أمهات أطفال المعاقين ذهنياً. مجلة دراسات في الطفولة والتربية، جامعة أسيوط، كلية التربية للطفولة المبكرة.

محمد، عبير (٢٠١٩). العنف الزوجي وعلاقته بالشفقة بالذات في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. مجلة كلية التربية، ٣٠ (١٢٠).

محمد، نجوى إبراهيم عبدالمنعم. (٢٠١٨). الشفقة بالذات وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة من آباء وأمهات ذوي الإعاقة العقلية. مجلة التربية الخاصة والتأهيل، ٧ (26).

مختار، وحيد، محمد، محمد. (٢٠١٧). دراسة استكشافية لتفاعل الشفقة بالذات والرفاهية النفسية في خفض الاكتئاب لدى أمهات أطفال الروضة في ظل جائحة كورونا وتأثيره على المهارات الاجتماعية لأطفالهن. مجلة الطفولة والتربية، جامعة الإسكندرية، ٤٥ (١٣).

مرسي، أماني جلال محمد. (٢٠١٨). التحقق من إستراتيجية التقليد في تحسين حالة الأطفال ذوي اضطراب التوحد وأثره في الوصمة الاجتماعية والضغوط النفسية لدى أمهاتهم. مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة. ٢٦ (٤).

المنشاوي، عادل محمود. (٢٠١٦). نموذج سببي للعلاقات المتبادلة بين الشفقة بالذات وكل من الإرهاق والصمود الأكاديمي لدى الطالب المعلم. مجلة كلية التربية بالإسكندرية - مصر، ٢٦ (٥).

مؤسسة داون سندروم. (٢٠٠١). نحو غد مشرق لأولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة، لست وحدي في هذا العالم، كيف نساعد أولادنا حاملي متلازمة داون، التدخل المبكر. (ترجمة: المجموعة الاستشارية لتنظيم المعلومات والإدارة، القاهرة). الجزء (4).

ثانياً: لمراجع الأجنبية:

- Akin,A.,&Akin, U (2015). Des self- compassion predict spiritual experiences of Turkish University students ?. Journal of religion and health, 56 (1).
- Arnos, O. (2017). Perceived stress levels and levels of self-compassion of parents of children with communication disorders. (M.A) Illinois State ity.

- Aydan, A. (2015). A comparison of the alexithymia, self-compassion and humour characteristics of the parents with mentally disabled and autistic Children. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, (174).
- Breines , J.& Chen. (2012). Self- compassion Increases SelfImprovement Motivation. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(9).
- Dcborah Serani. (2011). *Living With Depression* , Rowman & Littlefield.
- Dehnavi,R.,Nouri,A.,Jafari,M.,& Faramarzi ,S. (2008). Investigating stigma phenomenon among mothers with down syndrome children in Isfahan: Apsycho-social approach. *Journal of Family Research*, 5(3).
- Dzwonkowska, I & Lykus, A. (2015). Self-compassion and social functioning of people- research review, *polish psychological bulletin*, 46(1).
- Hemmati,S.,Solemani ,F., Seyednour , R., & Dadkhah , A. (2010). Stigma in Iranian down syndrome.Iranian Rehabilitation Journal , 8 (11).
- Kalnins, G. (2015).Ajourney with self-compassion: exploring self-compassion within the context of the Christian faith, (M.A). Trinity western university.
- Kirkpartick, K. (2005). Enhancing Self-Compassion using a Gestalt two-chair intervention, University of Texas at Austin, August.
- Kristiana, I. (2017). Self-compassion and parenting stress in mothers of children with cognitive disability. *Jurnal Ecopsy*, 4, (1).
- labeling: pedagogy and politics, New York, routledgefaimer.
- Lawrcnce Blume. (2002). *Stigma and Social Control* ,New York ,Ithaca, Cornell University, Economics Series.
- Neef, K & Costigan, A. (2014). Self- Compassion, Wellbeing and Happiness. *Psychologie in Osterreich* , 2(3).

- Neff , K. D. (3003). Self- compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity.
- Neff,K.& Dahm, K. (2015). Self- compassion: what it is , what it does , and how it relates to mindfulness.Hand book of mindfulness and seif –regulation , (10).
- Neff,K.,(2003a). the development and validation of a scale to measure self - compassion. Self and Identity , 2(3).
- Neff,K.A,(2003b). Self- Compassion: an aiternative-conceptualization of a health attitude toward one self.Self and Identity,2 (3).
- Pommier , E,Neff,K,D,&Toth-Kiraly, I. (2020). The development and validation of the Compassion Scale.Assessment , 27 (1), 21-39
- Werner, S & C. Shuiman. (2015). Does type of disability make a difference in affiliate stigma among family caregivers of individuals with autism, Intellectual Disability or Physical Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 59 (3).
- Werner, S., & Shulman , C. (2013). Subjective well- being among family caregivers of individuals with developmental disabilities: The role of individuals with developmental moderating variables. Research in Develomental Disabilities.
- Wong, C., Mak, W., & Liao, K. (2016). Self-Compassion: A Potential Buffer Against Affiliate Stigma Experienced by Parents of Children with